ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

Pro Medicus Limited

PME · ASX (Australian Securities Exchange) · ISIN AU000000PME8 · Salud

Fecha de corte de los datos: **12 oct 2026** · Divisa: **AUD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Vender**	Precio **168,37 AUD**	Objetivo 12 m **214,57 AUD**	Rentabilidad 12 m **+27,8 % (base +23,4 %)**
Valor intrínseco **50,61 AUD · mercado 58,79**	Convicción **Alta**	Capitalización **17.622 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **60,5x**
Deuda neta aj. / EBITDA **-0,8x**			

Nombre	**Pro Medicus Limited**	Ticker / ISIN	**PME / AU000000PME8**
Mercado	**ASX (Australian Securities Exchange)**	Índice de referencia	**S&P/ASX 200**
Sector / industria	**Salud / Tecnología sanitaria (Health Care Technology)**	Sede · fundación	**450 Swan Street, Richmond, Victoria (Melbourne) · 1983**
Empleados	**153**	Web	**https://www.promed.com.au**
Precio (fecha)	**168,37 (12 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**107,75 – 300,00**
Acciones diluidas (M)	**104,7**	Free float	**51,1 %**
Capitalización	**17.622 M AUD**	Valor empresa	**17.282 M AUD**
Volumen medio diario	**≈ 39,2 M AUD/día (222.429 acciones; 3 meses, 66 sesiones)**	Próximos resultados	**15 feb 2027**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Vender · Convicción Alta · Objetivo a 12 meses **214,57 AUD** frente a 168,37 · Rentabilidad a 12 meses **+27,8 % (base +23,4 %)** · Valor intrínseco 50,61 AUD · con la prima implícita del mercado: 58,79 (-65,1 %) · Alcista / bajista -58,7 % / -83,5 %

La recomendación y por qué. Vender, con convicción alta. Nuestro valor objetivo es 50,61 AUD frente a un precio de 168,37 (cierre del 12-oct-2026 en la ASX): una rentabilidad total esperada del −69,5 % con el dividendo. Incluso el escenario alcista (69,54 AUD) queda un 58,7 % por debajo del precio; el bajista pierde el 83,5 %. La razón, en una frase: Pro Medicus es probablemente el mejor negocio de software sanitario cotizado, pero el precio exige un crecimiento del 33,0 % anual durante diez años, frente al 16,1 % de nuestro caso base, que ya es generoso. La convicción es alta porque las dos reglas dan Vender (también con la prima de riesgo que hoy pide el mercado: 58,79 AUD, −64,7 %) y la diferencia no es de tasa de descuento sino de lo que hay que creer; la bajaríamos si el primer semestre de FY2027 (febrero de 2027) creciera por encima del 30 % en AUD con un ingreso por estudio al alza. El plazo es lo menos seguro.

El negocio. Visage 7 cobra por estudio, con contratos de 5-10 años, renovaciones del 100 % y 1.340 M de ingresos mínimos contratados a cinco años [1, 6]. Gana un 74,9 % de EBIT sobre ventas, frente al 23,1 % de Sectra y el 11,2 % de Agfa HealthCare IT [18, 19], y su ROIC supera el 100 % todos los años frente a un WACC del 12,28 %. ¿Sostiene la calidad el crecimiento que proyectamos? En parte: no necesita capital, pero nuestro caso base ya la lleva del 11 % al 31,1 % de los estudios de EE. UU. en diez años, y el ingreso por estudio estimado no ha subido desde FY2024 [6].

Finanzas. Los ingresos de FY2026 crecieron un 22,9 % (28,4 % en moneda constante) hasta 261,7 M y el segundo semestre solo un 18,2 % en AUD [1]. El beneficio estatutario (265,3 M) lleva 174,2 M de plusvalías no realizadas de 4D Medical y Echo IQ; el subyacente fue 144,7 M [1]. La señal negativa: los clientes crecen un 55,7 %, más del doble que las ventas [1].

Equipo y gobierno. Los fundadores Hupert y Hall controlan de hecho la junta con el 46,3 % y solo cobran fijo; los consejeros compraron 5,98 M de acciones en los últimos 12 meses (los fundadores, 5,45 M), sin ventas [1]. Resta la falta de un plan de sucesión público y la salida del director financiero y del responsable de relaciones con inversores en 2026 [52, 53].

Valoración. El DCF da 45,92 AUD; con la prima del mercado, 56,51. Los comparables, entre 44,46 (EV/EBITDA) y 81,06 AUD (PER), porque Pro Medicus cotiza a 60,5 veces el EBITDA de los próximos 12 meses frente a 15,1 de la mediana. Quien compra hoy con nuestras cifras obtiene un 5,7 % anual, lo mismo que el bono australiano (5,40 %). Coincidimos con el consenso en los tres próximos años (−2,6 % a −3,5 % en ingresos [69]); la discrepancia es la década siguiente.

Riesgos y catalizadores. El riesgo para esta recomendación es que la nube convierta el PACS de los grandes sistemas de EE. UU. en un mercado de pocos ganadores y la cuota suba mucho más deprisa. Catalizadores: el congreso RSNA (29-nov a 3-dic-2026), los resultados del 1S27 (mediados de febrero de 2027) y las renovaciones de 2027. Los foros piden «comprar la caída», frente a un 3,94 % de posiciones cortas [59, 93].

Qué cambiaría la decisión. Compraríamos por debajo de 48,84 AUD y mantendríamos la venta por encima de 66,10. Revisaríamos a Mantener si el crecimiento semestral en AUD supera el 30 % dos semestres seguidos, si los contratos nuevos superan los 600 M en un año o si la empresa publica subidas de tarifa por estudio de más del 10 % en las renovaciones.

Resumen ejecutivo

Confianza: Media

Recomendación: Vender · Convicción: Alta · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **214,57 AUD** (rentabilidad +27,8 % (base +23,4 %)) · Valor intrínseco: 50,61 AUD (-69,9 % sobre 168,37) · con la prima implícita del mercado: 58,79 (-65,1 %)

Pro Medicus es un negocio excepcional: un software de imagen médica en la nube que cobra por estudio, gana un 74,9 % de EBIT sobre ventas y convierte casi todo en caja, sin deuda y sin compras [1]. Tiene ~11 % de los estudios de imagen de EE. UU., 11 de los 20 mejores hospitales del país y 1.340 M de ingresos mínimos contratados a cinco años [6]. Los ingresos han crecido un 26,5 % anual en nueve años.

El precio de 168,37 AUD valora la empresa en 17.622 M: 84,6 veces el EBITDA de los últimos 12 meses y 87,0 veces el beneficio de los próximos. El DCF inverso dice que, con márgenes del 80 % y un WACC del 12,28 %, los ingresos tendrían que crecer un 33,0 % anual durante diez años, más que en la última década y más de lo que da de sí todo el mercado de EE. UU. a su precio por estudio. Con nuestras cifras, comprar hoy rinde un 5,7 % anual.

El mercado acierta en la calidad y se equivoca en la duración. Para invertir hay que creer que Pro Medicus triplicará su cuota en EE. UU. y abrirá cardiología, patología y otros países al mismo ritmo, sin bajar precios frente a GE HealthCare-Intelerad y la IA [27]. Nuestro caso base ya supone pasar del 11 % al 31 % de cuota con un margen del 80 % y aun así vale 45,92 AUD.

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e (FY, jun), ponderado 25/50/25)	214,57 AUD
Bajista / base / alcista a 12 meses	83,0x × 1,80 = 149,40 · 97,7x × 2,12 = 207,12 · 127,0x × 2,32 = 294,64
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	27,8 % / 23,4 %
Regla de múltiplos aplicada	v2: base = mín(actual, mediana 5 a) con la historia al cierre; bajista mín. 5 a o base × 0,85; alcista techo base × 1,30
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	202,47 (nuestro base +2,3 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	50,61 AUD
Potencial sobre el precio actual	-69,9 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	0,4 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	-69,5 %
Escenario alcista / bajista	-58,7 % / -83,5 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	-0,70x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	5,7 % frente a 12,3 % y 10,7 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 10,7 %)	58,79 AUD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	-64,7 %
Asimetría con la prima del mercado	-0,59x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Vender
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Vender
Crecimiento anual implícito en el precio (FY2027e-FY2036e) frente al previsto para su mercado	33,0 % frente a 3,7 %
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	En parte (16,1 % anual proyectado; sin inversión neta)

Elemento de la decisión	Valor
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Vender
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener
Convicción según los criterios (las dos reglas dan Vender, rentabilidad del -69,5 % (-64,7 % con la prima del mercado) y el precio pide 16,9 puntos más de crecimiento que el caso base)	Alta

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 50,61 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 50,61 y 239,18
Vender o reducir	Por encima de 239,18 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Si el precio baja de 48,84 AUD, pasaríamos a Comprar.
- Si el crecimiento de ingresos en AUD supera el 30 % en el 1S27 y el 2S27, revisaríamos a Mantener.
- Si los contratos nuevos de FY2027 superan los 600 M (407 M en FY2026), revisaríamos el caso base al alza.
- Si la empresa publica subidas de tarifa por estudio superiores al 10 % en las renovaciones de 2027, subiríamos el crecimiento de precio del puente.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

Un crecimiento del 33,0 % anual durante diez años con márgenes del 80 %: ingresos de unos 4.500 M en FY2036, frente a 261,7 M hoy. El mercado trata la caída del 44,6 % del último año como una oportunidad y el consenso tiene un precio objetivo medio de 202,47 AUD [70].

Lo que creemos nosotros.

Un crecimiento del 16,1 % anual de media en diez años, empezando por un 26 % en FY2027 (un 2,6 % por debajo del consenso), y margen EBITDA del 80 %. Eso ya lleva la cuota de EE. UU. del 11 % al 31 % y da 45,92 AUD por acción.

Por qué podemos tener razón.

El tamaño del mercado pone techo: 690 M de estudios al año que crecen un 3 % y un ingreso por estudio estimado que no ha subido en dos años [6]. El precio pide más ingresos de los que hay en todo el mercado de EE. UU. a su tarifa. La caída de 2026 vino del múltiplo, no de las cifras, y el múltiplo sigue en 60,5 veces el EBITDA.

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	45,92	-72,7 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	62,76	-62,7 %	25 %
Transacciones precedentes (no se usa)	24,51	-85,4 %	0 %
Escenarios ponderados	47,28	-71,9 %	35 %

A favor

- **Margen único en el sector**: EBIT del 74,9 % frente al 23,1 % de Sectra [18].
- **Ingresos asegurados**: 1.340 M de mínimos contratados a cinco años, +41 % [6].
- **Renovaciones del 100 %** con tarifa por estudio más alta en FY2026 [1].
- **Sin capital**: ROIC por encima del 100 % y reinversión del 2 % del beneficio operativo.
- **Fundadores alineados**: 46,3 % del capital; los consejeros compraron 5,98 M en 12 meses [1].

En contra

- **El precio pide un 33,0 % anual** durante diez años; nuestro caso base, un 16,1 %.
- **Múltiplo extremo**: 60,5 veces el EBITDA de los próximos 12 meses frente a 15,1 de la mediana.
- **Freno visible**: el 2S26 creció un 18,2 % en AUD [1].
- **Cobro que empeora**: clientes +55,7 % con ventas +22,9 % [1].
- **Ruido contable**: 174,2 M de plusvalías no realizadas en el beneficio de FY2026 [1].
- **Competencia con escala**: GE HealthCare compró Intelerad por 2.300 M USD [27].

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende de que el crecimiento baje a ritmos del 15-20 % en dos o tres años, como en cualquier empresa que ya tiene el 11 % de su mercado. La señal de que nos equivocamos sería un primer semestre de FY2027 por encima del 30 % en AUD con contratos nuevos de más de 300 M en el semestre y renovaciones con subidas de tarifa de dos dígitos: eso indicaría que la cuota y el precio pueden crecer a la vez durante más tiempo del que suponemos.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
Crecimiento semestral de ingresos en AUD	18,2 % (2S26)	Por encima del 30 % dos semestres seguidos	Es lo que necesita el precio.
Contratos nuevos (valor mínimo)	407 M en FY2026	Más de 600 M al año	Mide la ganancia de cuota futura.
Cuota de estudios de EE. UU.	~11 %	Más de 15 % en ago-2027	Nuestro caso base supone +2 puntos al año.
Clientes vencidos a más de 90 días	6,7 M	Más de 10 M	Calidad del cobro.
Margen EBIT subyacente	74,9 %	Por debajo del 72 %	Señal de presión de precios o de gasto comercial.

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**84,6x / 60,5x**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**121,7x / 87,0x**
EV/EBIT últimos 12 m	**88,1x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**66,04x**	Rentabilidad por FCF	**0,7 %**

Rentabilidad por dividendo	**0,4 %**	Crecimiento anual de ingresos (FY2017-FY2026)	**26,5 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**78,0 %**	ROIC último ejercicio	**110,5 %**
WACC	**12,3 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**-1,2x · -0,8x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**12 de 13 (1 sin dato)**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Alta

Pro Medicus fue fundada en Melbourne en 1983 por el médico de familia Sam Hupert y el ingeniero de software Anthony Hall, que siguen en el consejo como consejero delegado y director de tecnología [1]. Empezó con software de gestión de consultas y de radiología (RIS) y una red de e-salud en Australia, y salió a la ASX en 2000 [1][30]. En enero de 2009 compró con caja propia Visage Imaging, filial de imagen de Mercury Computer Systems con unos 1.200 clientes, en plena caída de precios de los activos [30]. Visage 7, el visor por streaming, es hoy el núcleo del negocio. La entrada en los grandes hospitales de EE. UU. se aceleró con Mayo Clinic (2016) y siguió con Partners Healthcare, NYU Langone, Baylor Scott & White y Trinity Health, el mayor contrato de su historia (330 M AUD, 2024) [31][33][6]. Hupert dejó de ser CEO en 2007 y volvió en 2010 [1].

Año	Hito
1983	Sam Hupert y Anthony Hall fundan Pro Medicus en Melbourne [1].
2000	Salida a bolsa en la ASX [1].
2004	Acuerdo de 3 años y 10 M AUD con Agfa North America para licenciar en exclusiva su software de gestión y radiología digital en EE. UU. y Canadá [30].
2009	Compra de Visage Imaging (Carlsbad, California; antes filial de Mercury Computer Systems, ~1.200 clientes) con caja propia, sin ampliación de capital [30].
2013	Contrato «pivotal» con v-Rad (telerradiología, EE. UU.); en 2013 firma también 4 M USD con una red de Veterans Affairs [33].
2016	Contrato de 6 años y ~18 M AUD, por transacción, con Mayo Clinic para implantar Visage 7 en toda su radiología [31][32].
2018	Contrato de 27 M AUD y 7 años con Partners Healthcare (Boston) y primer Visage 7 Open Archive con Mercy [33].
2020	NYU Langone (25 M AUD) y Northwestern (22 M AUD); desde septiembre de 2020 todas las implantaciones nuevas en IDN son en la nube [33][6].
2023	Baylor Scott & White: 140 M AUD a 10 años [33].
2024	Trinity Health: 330 M AUD a 10 años, el mayor contrato de su historia; renovación de Mercy por 98 M AUD a 8 años [33][6].
2025	UCHealth (Colorado): 170 M AUD a 10 años, el segundo mayor, con cardiología («full stack + 1») [6].
2026	FY26: 10 contratos nuevos por 407 M AUD, 6 de 6 renovaciones a precio por transacción más alto, ~11 % de los estudios de imagen de EE. UU. [6].

2. Modelo de negocio

Confianza: Alta

Pro Medicus vende software de imagen médica empresarial. Su producto principal es la plataforma Visage 7 (de su filial Visage Imaging, con I+D en Berlín y sede norteamericana en San Diego): Viewer (visor diagnóstico que transmite las imágenes por streaming en lugar de comprimirlas y enviarlas), Open Archive (archivo neutral, VNA), Workflow (listas de trabajo), y extensiones a cardiología, patología digital, informes con IA (lanzado en 2026) y la app Visage Ease, incluida una versión para Apple Vision Pro [6][1]. Se despliega en la nube (AWS, Azure o Google) o en el centro de datos del cliente [6]. En Australia vende Visage RIS a los dos mayores grupos de radiología, Lumus (Primary Healthcare) e I-MED, y la red de e-salud Promedicus.net [6][1]. Sus clientes son centros médicos académicos, sistemas hospitalarios (IDN) y grupos privados de radiología, sobre todo en EE. UU. (90,5 % de los ingresos de FY26), además de Alemania y Australia [6]. Tiene 153 empleados (135 en FY25) [1].

Cómo gana dinero

Cobra sobre todo por estudio leído o archivado («pay per view»), con mínimos anuales garantizados en contratos de 5 a 10 años; lo que pasa del mínimo se reconoce cuando ocurre [1]. Ingresos de FY26 por tipo: exámenes y licencias 192,1 M AUD (73 %), soporte 34,8 M AUD y el resto migración de archivos y servicios profesionales [6]. La instalación, la licencia, las transacciones y el soporte forman una sola obligación de desempeño, que se reconoce a lo largo del contrato desde la puesta en marcha [1]. Los costes son casi todos de personal (gasto en empleados 42,1 M AUD en FY26) y la plantilla es pequeña, así que cada estudio adicional cae casi entero al resultado: margen EBIT subyacente del 74,9 % (74,0 % en FY25) [6][1]. Los ingresos mínimos contratados para los próximos cinco años eran 1.340 M AUD a jun-2026 (+41,3 %) [6].

Segmentos (FY2026)

Segmento	Ingresos	% del total	Crecimiento	Margen	Tipo de margen
Norteamérica	237	90,5 %	+24,1 %	2,3 %	EBIT
Australia	19	7,2 %	+7,0 %	1.004,4 %	EBIT
Europa	6	2,2 %	+35,3 %	-24,3 %	EBIT
Otros ingresos no asignados	0	0,0 %	-4,0 %	–	–



Ingresos por segmento	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Norteamérica	74	105	141	191	237
Australia	15	16	17	18	19
Europa	5	4	4	4	6
Otros ingresos no asignados	–	0	0	0	0



Clientes, recurrencia y poder de precios

Ningún cliente supera el 10 % de los ingresos del grupo en FY26 ni en FY25 [1]. Aun así, el mayor contrato, Trinity Health (330 M AUD a 10 años, ~33 M AUD anuales implícitos), equivale al 12,6 % de los ingresos de FY26 cuando esté implantado del todo (cálculo); estaba implantado al 71-75 % a 30-jun-2026 y al 87 % en ago-2026, y debía terminarse en oct-2026 [6]. Otros grandes: UCHealth (170 M AUD/10 años), Baylor Scott & White (140 M AUD/10 años), Mercy (98 M AUD/8 años), Beth Israel Lahey (90 M AUD/7 años) [6][33]. Las renovaciones de FY26 (6 de 6, 141 M AUD, todas a 5 años) se firmaron con un precio por transacción más alto [6]; el CEO habla de una tasa de renovación del 100 % y de que PME es la opción más cara del mercado [12]. El valor total firmado por año pasó de 157 M AUD (FY22) a 680 M (FY25) y 548 M (FY26) [6]. La empresa no publica el precio por estudio.

Indicadores operativos

Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Contratos nuevos (valor mínimo contratado, TCV)	FY25: 511 M AUD	FY26: 407 M AUD (10 contratos: 9 EE. UU., 1 Europa)	−20 %	FY22 100; FY23 88,5; FY24 245 M. FY25 incluye Trinity Health (330 M, 10 años) [6].
Renovaciones (TCV)	FY25: 169 M AUD	FY26: 141 M AUD (6 de 6, más 2,8 M de ampliación VISN23)	−17 %	Todas a 5 años y con mayor precio por estudio; FY22 57; FY23 15,5; FY24 19 M [1, 6].
Ingresos mínimos contratados a 5 años	jun-25: 948 M AUD	jun-26: 1.340 M AUD	+41,3 %	jun-24: 624 M. Incluye las renovaciones que vencen dentro de los 5 años [6].
Implantaciones (go-lives)	n.d.	FY26: 16 (incluidas cuatro cohortes de Trinity)	–	El informe anual habla de 13 nuevas puestas en marcha de clientes y la presentación de 16 go-lives [1, 6]. Trinity: 5 de 7 cohortes completadas (87 %) según la presentación [6].
Cuota del mercado de EE. UU. (según la empresa)	1S26: más del 10 %	FY26: ~11 %	–	Incluye 11 de los 20 mayores centros sanitarios de EE. UU. según el CEO [6, 12, 13].
Empleados	135	153	+13,3 %	Gasto de personal FY26 42,1 M (+16,0 %) [1].
TCV firmado total	FY25: 680 M AUD	FY26: 548 M AUD	−19 %	Cinco años (FY22-FY26): 1.753 M [6].

3. Sector y mercado

Confianza: Media

Software de imagen médica empresarial (enterprise imaging): PACS y visor diagnóstico, archivo neutral (VNA) y flujo de trabajo de radiología, con extensiones a cardiología y patología digital, vendido a hospitales, sistemas sanitarios integrados (IDN), centros académicos (AMC) y grupos privados de radiología. El mercado que más pesa es EE. UU. (90,5 % de los ingresos de PME en FY26: 236,8 de 261,7 M AUD [6]). La empresa define su mercado direccionable en volumen: 690 M de estudios de imagen al año en EE. UU. [6]. Para el tamaño en dinero se usa Signify Research (imagen médica IT mundial: radiología, cardiología, visualización avanzada, flujo operativo) [20][21][22] y, como contraste para EE. UU., dos editores de informes de mercado sobre PACS (Arizton [23] y Market Glass vía Research and Markets [24]).

Tamaño del mercado	**Mundo, imagen médica IT: más de 5.500 M USD en 2023 (+5,5 %) y 6.600 M USD previstos en 2028 [21] [22]. EE. UU., solo PACS: 981 M USD en 2023 según Arizton (1.270 M USD en 2029e, TCAC 4,5 %) [23] y 908 M USD en 2024 según Market Glass [24]. Volumen: 690 M de estudios de imagen al año en EE. UU. según PME (ago-2026) [6].**	Posición en el ciclo	**Madurez del ciclo**
		Crecimiento previsto anual	**3,7 %**
		Estructura	**Moderadamente concentrada**



Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Volumen de estudios de imagen en EE. UU.	+	Estructural	690 M de estudios al año, +~3 % anual; los clientes de Visage crecen ~8 % [6]. Serie de PME: 650 M (2024), 670 M (2025), 690 M (2026) [16][15][6].
Tamaño de los estudios (TAC de conteo de fotones, tomosíntesis, patología digital)	+	Estructural	Los archivos pasan de 2-3 GB a 6-10 GB [1]; TAC de conteo de fotones con más de 10.000 imágenes; patología digital de más de 10 GB, hasta 30 GB en citología [6].
Migración a la nube y al modelo de suscripción	+	Estructural	PACS en la nube >65 % del mercado de EE. UU. en 2023 [23]; ingresos recurrentes de nube de Sectra Imaging IT +56,6 % en 2025/26 [18]; pedidos de nube de Agfa HealthCare IT +38 % en 2025 [19]; todas las implantaciones de PME en IDN son en la nube desde sep-2020 [6].
Escasez de radiólogos y lectura remota	+	Estructural	PME cita escasez mundial de radiólogos, menos residentes y trabajo desde casa como parte obligada del modelo [6][1].
Márgenes de los hospitales de EE. UU.	+/−	Cíclico	Índice de margen operativo de Kaufman Hall: 4,5 % en jun-2026; acumulado del año 2,5 %, un 6 % menos que en el 1S25 [29].
Fin del ciclo de reposición de PACS en mercados maduros	−	Cíclico	Signify Research preveía desaceleración en EE. UU. desde 2025 al acabar los ciclos de reposición [21].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	3	Muchos proveedores (Arizton cita nueve en EE. UU.: Sectra, Fujifilm, Change Healthcare, Philips, Agfa, Intelerad, GE Healthcare, Carestream, IBM) [23] y concentración en marcha (GE HealthCare compró Intelerad por 2.300 M USD en mar-2026) [27]. Pero los márgenes difieren mucho: EBIT del 74,9 % en PME frente a 23,1 % en Sectra Imaging IT y 11,2 % en Agfa HealthCare IT [6][18][19].
Poder de los clientes	3	Compran grandes sistemas hospitalarios y centros académicos por concurso (RFP) [6]. Aun así, PME renovó 6 de 6 contratos en FY26 con precio por transacción más alto [6] y ningún cliente pesa más del 10 % de sus ingresos [1].
Poder de los proveedores	2	Los insumos son sobre todo personal técnico (153 empleados en PME) y nube pública; PME trabaja con AWS, Azure y Google, sin depender de una sola [6][1].
Amenaza de entrada	2	Exige aprobación FDA 510(k) y equivalentes [1], cero fallos en un sistema crítico y referencias de clientes; PME cita el efecto red de las referencias en un sector conservador [12] y que la competencia tarda años en implantar un gran proyecto [12].
Amenaza de sustitutos	2	La tesis de que la IA o los desarrollos propios sustituyan al software (la «SaaSpocalypse») no se ha visto en las renovaciones de PME, según su CEO [12]; PME presenta la IA como algo que se integra en su visor [1].

Ciclo

Indicadores: Signify Research esperaba que el mercado mundial se frenara en 2025-2026 al terminar los ciclos de reposición en Norteamérica y Europa occidental [21]; el margen de los hospitales de EE. UU. en 2026 va por debajo de 2025 (2,5 % acumulado en el 1S26) [29]. Aun así, PME firmó en FY26 su segundo mejor año de contratos (548 M AUD) [6] y su CEO dice no ver efecto de los tipos de interés en las ventas [12]. En 2008-09 PME aprovechó la caída de precios para comprar Visage con caja [30]; en 2020 la pandemia aceleró la lectura remota [1]. No hay dato del sector para 2022.

Regulación

El software de diagnóstico de PME pasa por la FDA (510(k)) en EE. UU. y por los reguladores de cada país, que exigen demostrar equivalencia clínica con dispositivos ya comercializados [1]; su algoritmo de detección de cáncer de mama, desarrollado con NYU, está pendiente de autorización de la FDA [6]. Los datos de pacientes están sujetos a HIPAA en EE. UU. y GDPR en Europa; PME tiene un informe de cumplimiento HIPAA y la certificación SOC 2 Type II para Visage 7 PACS [1]. La obligación de historia clínica electrónica en EE. UU. empuja la demanda de imagen digital [1]. La regulación específica de IA está en desarrollo en varios países [1]. En Australia, PME prepara la información climática obligatoria de la ASX [1]. GE HealthCare cita como riesgos los aranceles y los cambios en el reembolso de pagadores públicos y privados [26].

Tendencias y disrupción

Nube: el mercado se desplaza a la nube y al cobro por uso (Sectra, Agfa y PME lo confirman) [18][19][6]. IA: PME se presenta como la «puerta de entrada» de la IA de imagen porque su visor es el escritorio del radiólogo, invierte en Elucid, 4DMedical y Echo IQ y co-desarrolla con NYU [6][12]. Plataforma única: cardiología (UCHealth, Vancouver Clinic, MedStar), patología digital en producción en Europa y módulo de informes con IA para EE. UU. en el 1S del año natural 2027 [6][12]. Consolidación: GE HealthCare compró Intelerad (2.300 M USD; ~270 M USD de ingresos previstos, ~90 % recurrentes, margen EBITDA ajustado >30 %) para competir en la nube y en ambulatorio [27]. Sectra crece más rápido en EE. UU. [18].

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**11,0 %**	Posición	**Proveedor independiente de visor/PACS/archivo con ~11 % de los estudios de imagen de EE. UU. (medido por volumen de estudios de sus clientes) [6]; 11 de los 20 mejores hospitales de EE. UU. (ranking 2026/2027) usan Visage 7 como PACS [6]. En Australia es líder en RIS con contratos con Lumus e I-MED [6]. En Alemania, base creciente (Heidelberg) [6].**
Foso	**Amplio**	Tendencia del foso	**Estable**

Competidor	País	Cotiza	Ingresos (M)	M. EBIT	Cómo compite
Sectra (Imaging IT Solutions)	Suecia	SECT-B	461	23,1 %	Ejercicio may-2025 a abr-2026: ventas del segmento 3.057,4 M SEK (+9,3 %), resultado operativo 706,8 M SEK; ingresos recurrentes de nube +56,6 %; EE. UU. es su zona de mayor crecimiento [18]. Convertido a 0,1508 AUD/SEK (BCE, 30-abr-2026) [25].
GE HealthCare (segmento Imaging, incluye Intelerad desde mar-2026)	EE. UU.	GEHC	13.833	9,6 %	Segmento Imaging 2025: 9.245 M USD de ventas y EBIT de 891 M USD; incluye equipos (TAC, RM, rayos X), no desglosa el software de imagen [26]. Compró Intelerad (PACS en la nube, fuerte en ambulatorio) por 2.300 M USD el 18-mar-2026: ~270 M USD de ingresos previstos el primer año, ~90 % recurrentes, margen EBITDA ajustado >30 %, crecimiento de dos dígitos bajos [27]. Convertido a 1,4963 AUD/USD (BCE, 31-dic-2025) [25].
Intelerad (ya dentro de GE HealthCare)	Canadá/ EE. UU.	–	404	–	Ingresos previstos ~270 M USD el primer año completo bajo GE HealthCare (estimación de GEHC, no cuentas propias); margen EBITDA ajustado >30 % [27]. Convertido a 1,4963 AUD/USD [25].
Agfa HealthCare IT (Agfa-Gevaert)	Bélgica	AGFB	408	11,2 %	2025: ventas 232 M EUR (−4,1 %; −1,1 % sin divisa), EBIT ajustado 26,0 M EUR, EBITDA ajustado 14,5 %; pedidos +14 % (187 M EUR), de nube +38 %; el 43 % de los pedidos, de clientes nuevos; Norteamérica es su mercado principal [19]. Convertido a 1,7581 AUD/EUR (BCE, 31-dic-2025) [25].
Philips (Connected Care, incluye Enterprise Informatics)	Países Bajos	PHIA	–	10,7 %	Margen EBITA ajustado de Connected Care en 2025: 10,7 %; ventas comparables +3 %; grupo 17.800 M EUR [28]. No se obtuvo la cifra de ventas del segmento ni el peso de la informática de imagen.
Fujifilm (Synapse)	Japón	4901	–	–	Proveedor clave de PACS en EE. UU. según Arizton [23]. Sin cifras del negocio de software de imagen en fuentes gratuitas consultadas.
Merative (antes IBM Watson Health / Merge)	EE. UU.	–	–	–	Privada (Francisco Partners); Arizton cita a IBM entre los proveedores clave [23]. Sin cuentas públicas.



Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	2	Efecto de referencias: el CEO dice que cuanto mayor es la base de clientes más referencias, clave en un sector conservador [3]; 11 de los 20 mejores hospitales de EE. UU. usan Visage 7 [1]. No hay efecto de red en sentido estricto entre usuarios.
Costes de cambio	4	Contratos de 5-10 años; 6 de 6 renovaciones en FY26, todas con precio por transacción más alto, y tasa de renovación del 100 % según el CEO [1][3]; cambiar exige migrar el archivo de imágenes (PME factura la migración de archivos como línea de ingresos) [1][2]; la competencia tarda años en implantar un gran proyecto [3].
Intangibles (marca, patentes, licencias)	3	Tecnología de streaming y arquitectura sobre GPU [2]; autorizaciones FDA 510(k) [2]; reputación en centros académicos (Mayo, NYU, Yale, Northwestern) [22][1].
Ventaja en costes	4	Margen EBIT subyacente 74,9 % en FY26 [1] frente a 23,1 % de Sectra Imaging IT [7], 11,2 % de Agfa HealthCare IT [8] y 9,6 % del segmento Imaging de GE HealthCare [15]; el CEO dice que es unas tres veces el de sus competidores más cercanos [3]; ingresos por empleado ~1,7 M AUD (261,7 M / 153) (cálculo) [1][2]; implantaciones en 1/4-1/5 del tiempo habitual [1].
Escala eficiente	2	El mercado tiene sitio para varios proveedores: PME tiene ~11 % de los estudios de EE. UU. y al menos nueve competidores relevantes [1][12].

Amenazas

Hechos: GE HealthCare integra Intelerad (PACS nativo en la nube, 270 M USD de ingresos) en su negocio Imaging desde mar-2026 [27]; Sectra crece más en EE. UU. que en ningún otro sitio y su nube crece un 57 % [18]; Agfa gana pedidos de nube en Norteamérica, el 43 % de clientes nuevos [19]. Signify esperaba menos inversión en EE. UU. al acabar el ciclo de reposición [21]. El CEO admite que PME es la opción más cara del mercado y menciona el temor del mercado a que la IA traiga competidores más baratos o desarrollos propios [12]. La empresa cita la obsolescencia tecnológica y la ciberseguridad entre sus riesgos [1].

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec.	M. bruto	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
FY2017	32	–	98,4 %	18	58,4 %	14	44,8 %	9	0,09	0,04	31 %
FY2018	36	+13,8 %	99,4 %	22	60,6 %	17	46,9 %	13	0,12	0,06	27 %
FY2019	50	+39,3 %	97,2 %	32	63,0 %	25	50,8 %	19	0,18	0,10	27 %
FY2020	57	+13,4 %	99,4 %	38	66,4 %	30	52,9 %	23	0,22	0,12	23 %
FY2021	68	+19,5 %	99,3 %	50	73,0 %	42	62,4 %	31	0,29	0,15	28 %
FY2022	93	+37,7 %	99,5 %	70	74,6 %	62	66,8 %	44	0,42	0,22	30 %
FY2023	125	+33,6 %	99,6 %	92	73,5 %	84	67,2 %	61	0,58	0,30	30 %
FY2024	162	+29,3 %	99,8 %	121	74,8 %	112	69,5 %	83	0,79	0,40	29 %
FY2025	213	+31,9 %	99,9 %	165	77,4 %	158	74,0 %	115	1,10	0,55	29 %
FY2026	262	+22,9 %	99,8 %	204	78,0 %	196	74,9 %	265	2,54	0,69	30 %

Crecimiento anual compuesto FY2017-FY2026: ingresos **26,5 %**, EBITDA **30,6 %**, BPA **44,9 %**.



Los ingresos se multiplicaron por 8,3 en nueve años (de 31,6 M en FY2017 a 261,7 M en FY2026), sin compras: todo es crecimiento orgánico de Visage 7 en EE. UU., que ya es el 90,5 % de las ventas [1]. El margen EBITDA operativo subió de 58,4 % a 78,0 % y el EBIT de 44,8 % a 74,9 %: el coste es casi todo personal (153 empleados) y cada estudio adicional apenas cuesta, porque los clientes alojan las imágenes en su nube [1, 6]. FY2026 marca un freno: +22,9 % reportado frente al +31,9 % de FY2025; en moneda constante fue +28,4 %, porque el AUD se apreció de 0,647 a 0,678 USD [1]. El segundo semestre creció solo un 18,2 % en AUD, porque muchas implantaciones (cuatro cohortes de Trinity, UC Health, BayCare) entraron tarde y no aportaron en el año [12]. El beneficio estatutario de 265,3 M no es comparable: lleva 174,2 M antes de impuestos de plusvalías no realizadas de 4D Medical y Echo IQ [1].

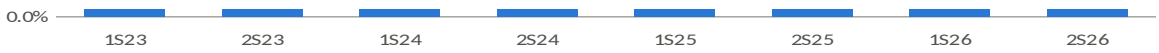
Ajustes y partidas no recurrentes

Usamos cifras reportadas con un ajuste: las ganancias de valor razonable de inversiones financieras y las diferencias de cambio, que la empresa presenta entre los gastos operativos, salen del EBITDA y del EBIT como no recurrentes (FY2026: −172,3 M; FY2025: 2,0 M de pérdida de cambio) [1]. Con ello el EBIT coincide con el EBIT subyacente que publica la empresa (196,1 M en FY2026; 157,7 M en FY2025) [1, 10]. El LTM usa el beneficio neto subyacente (144,7 M; BPA 1,383 AUD) para los múltiplos, no el estatutario (265,3 M; 2,536 AUD). En FY2026 la empresa redefinió su beneficio antes de impuestos subyacente para incluir los intereses cobrados (FY2025 reexpresado a 165,2 M) [1]. No hay costes de reestructuración ni deterioros recurrentes.

6. Resultados recientes

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	EBITDA	M. EBITDA	BPA
1S23	57	+28,3 %	41	72,3 %	0,26
2S23	68	+38,4 %	51	74,5 %	0,32
1S24	74	+30,3 %	53	72,0 %	0,35
2S24	87	+28,5 %	67	77,2 %	0,45
1S25	97	+31,1 %	73	75,2 %	0,49
2S25	116	+32,5 %	92	79,3 %	0,61
1S26	125	+28,4 %	94	75,6 %	1,64
2S26	137	+18,2 %	110	80,2 %	0,90



Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

Pro Medicus no hace conferencias con analistas: publica una entrevista escrita al CEO con preguntas de su agencia de relaciones públicas [11, 12]. En febrero de 2026 (HY26) el mensaje fue el récord de contratación (siete contratos por más de 280 M de mínimo), el contratado a 5 años por encima de 1.000 M y que Visage «no se puede replicar con o sin IA» [11]; la acción cayó un 23,9 % ese día [66]. En agosto de 2026 (FY26) el discurso cambió de los contratos a la ejecución: el resultado «en línea con lo esperado», el objetivo de +30 % de EBIT y beneficio cumplido solo en moneda constante, implantaciones que llegaron tarde y no contribuyeron a FY26 y un FY27 con doce meses completos de Trinity, UC Health y BayCare [10, 12]. Lo que no se trató: ninguna guía numérica para FY27, la caída de la acción, el EBIT por debajo del umbral del bonus de los directivos (199,5 frente a 210,0 M) y la bajada de 4D Medical después del cierre (de 182,0 a 149,1 M a 17-ago-2026) [1].

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
FY2017	47	15	3	23	0	0	-23	35	-1,2x
FY2018	56	17	8	25	0	0	-25	46	-1,2x
FY2019	84	18	-6	32	0	0	-32	49	-1,0x
FY2020	96	19	-9	43	0	2	-41	60	-1,1x
FY2021	126	20	-6	62	0	3	-59	82	-1,2x
FY2022	157	22	-7	91	0	2	-88	102	-1,3x
FY2023	202	21	-3	121	0	2	-120	139	-1,3x
FY2024	257	20	-5	155	0	2	-153	188	-1,3x
FY2025	339	21	3	211	0	2	-208	257	-1,3x
FY2026	610	22	18	252	0	2	-250	451	-1,2x

Periodo	Circulante / ventas	Días de cobro	Días de inventario	Días de pago	Ciclo de caja (días)	Liquidez corriente
FY2017	10,6 %	40	38	2.423	-2.345	4,2x
FY2018	21,2 %	75	90	4.962	-4.797	5,8x
FY2019	-11,7 %	131	8	886	-747	3,8x
FY2020	-15,2 %	89	36	2.711	-2.586	4,8x
FY2021	-8,2 %	123	25	2.775	-2.627	5,0x
FY2022	-7,3 %	107	60	4.396	-4.229	4,5x
FY2023	-2,2 %	117	37	4.563	-4.409	5,3x
FY2024	-3,0 %	109	59	12.368	-12.200	6,0x
FY2025	1,3 %	110	0	15.538	-15.428	6,5x
FY2026	6,8 %	137	0	13.433	-13.296	6,8x

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

Cambio de perímetro (FY2026: el activo total crece un 80 % y los ingresos un 23 %). Los ratios de balance de ese año (días, circulante, deuda neta / EBITDA, ROIC) y los indicadores de calidad contable no son comparables con los anteriores.

El circulante comercial pasó de −15,2 % de las ventas en FY2020 a +6,8 % en FY2026. La causa son los clientes: 98,0 M, un 52 % más con unas ventas un 23 % mayores, y los vencidos a más de 90 días suben de 1,0 a 6,7 M [1]. Con implantaciones grandes que facturan mínimos anuales y hospitales con márgenes del 2,5 % [29], es la señal de balance que más vigilamos. La caja y activos financieros corrientes suman 252,3 M (19,8 % más), después de pagar 64,8 M de dividendos y 10,1 M de recompras [1]. En el puente restamos el dividendo final de 38,7 M pagado el 29-sep-2026 y el impuesto latente estimado de la plusvalía de 4D Medical, y sumamos esa inversión a su cotización del corte (169,6 M) [1].

8. Flujos de caja

Confianza: Alta

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
FY2017	15	6	0	9	9	93 %	19,5 %	1,4x	0,08
FY2018	14	6	0	7	13	59 %	17,7 %	1,3x	0,07
FY2019	25	8	0	17	19	89 %	15,1 %	1,2x	0,16
FY2020	31	8	1	23	23	100 %	13,9 %	1,0x	0,22
FY2021	39	8	1	31	31	99 %	11,3 %	1,1x	0,29
FY2022	62	9	1	52	44	117 %	9,7 %	1,2x	0,50
FY2023	63	6	1	56	61	92 %	5,2 %	0,8x	0,53
FY2024	82	7	1	75	83	90 %	4,1 %	0,8x	0,71
FY2025	111	7	1	103	115	90 %	3,5 %	1,0x	0,99
FY2026	127	9	1	118	265	45 %	3,3 %	1,1x	1,13



Acumulado FY2017-FY2026: FCF **491**, conversión **74 %** del beneficio neto; adquisiciones 0, dividendos 238, recompras 27.

Pro Medicus convierte casi todo su beneficio en caja: 74 % de conversión acumulada en FY2017-FY2026 con el beneficio estatutario, y por encima del 90 % cada año con el subyacente [1]. En FY2026 el flujo operativo fue 127,5 M frente a 144,7 M de beneficio subyacente (88 %), lastrado por los clientes (+34 M) [1]. El capex es pequeño y casi todo es desarrollo activado: 8,2 M de 8,7 M, frente a 6,9 M de amortización de intangibles; los equipos apenas suman 0,4 M porque los clientes alojan el sistema en su nube [1]. A ese capex hay que añadir las comisiones de venta activadas (NIIF 15), que subieron de 4,9 a 11,3 M en el año (2,4 % de las ventas) y no pasan por el capex: las sumamos en el DCF. Estimación propia: el capex de mantenimiento es el desarrollo activado (~3 % de las ventas) y el de crecimiento, las comisiones. Los intereses cobrados (9,0 M) se clasifican en inversión [1].

9. Calidad contable

Confianza: Alta

Auditor	**Ernst & Young (Melbourne)**		
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**FY2026**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	69,51	Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo. No fiable en FY2026: cambio de perímetro (el balance incluye negocios sin su cuenta de resultados completa).
Piotroski F	6 / 9	Intermedio (4-6).
Beneish M	-0,43	No interpretable en FY2026: con un cambio de perímetro, los índices de activos, amortización y ventas (AQI, DEPI, SGI) comparan grupos distintos y el umbral de −1,78 no sirve.
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	0,86x	El beneficio se cobra solo en parte: mirar circulante y ajustes.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	Sí
Flujo operativo > beneficio neto	No
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	Sí
No emite acciones	Sí
Mejora el margen bruto	No
Mejora la rotación del activo	No

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Las cuentas son limpias en lo operativo y ruidosas en lo financiero. EY firma sin salvedades y sus dos asuntos clave son el reconocimiento de ingresos y la valoración de 4D Medical [1]. La partida que distorsiona es la plusvalía no realizada de 174,2 M: un préstamo de 10 M valorado con un modelo de opciones (nivel 2) que en agosto ya valía 33 M menos;

dobla el beneficio estatutario y saca el BPA de 1,38 a 2,54 AUD [1]. La remuneración en acciones es pequeña (4,2 M, 1,6 % de las ventas) porque los fundadores no cobran variable. El desarrollo activado (8,2 M) es estable y similar a su amortización. El Altman Z de 69,51 y el Piotroski de 6 reflejan una empresa sin deuda; el Beneish M de −0,43 está por encima del umbral de −1,78 porque los clientes crecieron mucho más que las ventas (índice de días de cobro alto) y por la plusvalía. No vemos manipulación, pero sí una calidad del cobro que empeora: es la señal a seguir.

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Ganancia no realizada de valor razonable dentro del beneficio	Alta	FY26: 174,2 M antes de impuestos; 4D Medical valorado con un modelo de opciones (nivel 2); asunto clave de auditoría; tras el cierre el valor bajaría 32,9 M con la cotización del 17-ago-2026 [1].
Activo de nivel 3 dentro de clientes	Baja	Derecho de suscripción de EchoIQ (2,354 M) registrado en «trade and other receivables» antes de desembolsar; revertiría si la operación no se cerrase (contrato firmado el 14-ago-2026) [1].
Capitalización de desarrollo	Baja	Capitalizado 8,2 M frente a 6,9 M amortizados en FY26 (3,1 % de los ingresos), vida útil 5 años; estable en 6-9 M al año desde FY17 [1, 2, 3, 4, 5].
Clientes vencidos	Media	Cuentas a cobrar a más de 90 días: 6,7 M a 30-jun-26 (1,0 M un año antes); clientes +55,7 % frente a ingresos +22,9 % [1].
Remuneración en acciones creciente	Baja	4,2 M en FY26 (1,6 % de los ingresos) frente a 0,6 M en FY17 [1, 5].
Cambio de definición de la métrica subyacente	Baja	En FY26 el beneficio antes de impuestos subyacente pasa a incluir los intereses (FY25 reexpresado a 165,2 M) [1].
Comisiones activadas	Baja	Costes de contrato (comisiones) activados: 11,3 M a 30-jun-26 frente a 4,9 M un año antes [1].

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Alta

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido
FY2017	81,6 %	26,8 %	19,7 %	29,5 %	0,67x	1,36x	12
FY2018	76,1 %	31,7 %	24,6 %	35,4 %	0,69x	1,29x	16
FY2019	99,7 %	40,3 %	27,2 %	38,2 %	0,71x	1,48x	19
FY2020	128,5 %	42,2 %	25,7 %	40,6 %	0,63x	1,64x	18
FY2021	147,0 %	43,5 %	27,9 %	45,4 %	0,61x	1,56x	21
FY2022	244,6 %	48,5 %	31,4 %	47,6 %	0,66x	1,54x	18
FY2023	362,5 %	50,4 %	33,8 %	48,6 %	0,70x	1,49x	16
FY2024	298,2 %	50,7 %	36,0 %	51,3 %	0,70x	1,41x	27
FY2025	268,3 %	51,8 %	38,7 %	54,1 %	0,71x	1,34x	41
FY2026	110,5 %	75,0 %	55,9 %	101,4 %	0,55x	1,34x	125

ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 113,3 % · **WACC**: 12,3 %.

Pro Medicus crea valor de forma extraordinaria: el ROIC ha estado por encima del 75 % todos los años desde FY2017 y por encima del 240 % en FY2022-FY2025, frente a un WACC del 12,3 %. Lo mueve el margen, no la rotación: el capital

operativo es casi nulo (intangibles de 22 M y circulante pequeño) porque la empresa no tiene fábricas, inventario ni centros de datos [1]. El ROIC de FY2026 (110,5 %) baja solo porque el capital invertido del motor incluye el préstamo de 4D Medical (182 M), que no es capital operativo; sin él estaría cerca del 250 %. El ROIC incremental del 113 % dice que el crecimiento ha sido de altísima calidad. Ningún competidor cotizado se acerca: Sectra Imaging IT gana un 23,1 % de EBIT sobre ventas y Agfa HealthCare IT un 11,2 % [18, 19]. La rentabilidad no está en duda; lo está cuánto tiempo puede reinvertirse a ese ritmo en un mercado de 690 M de estudios.

11. Deuda y solvencia

Confianza: Alta

Deuda neta a 30 jun 2026	**-250 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**-1,2x**
Pasivos asimilables a deuda (pensiones y otros)	**87 M**	Deuda neta ajustada	**-164 M**
Deuda neta ajustada / EBITDA	**-0,8x**	Liquidez disponible	**Sin deuda financiera. Caja 146,5 M + depósitos bancarios a plazo 69,6 M + activos financieros corrientes 36,2 M = 252,3 M a 30-jun-26 (210,7 M a 30-jun-25) [1]. Sin líneas de crédito comunicadas.**
Rating	**Sin rating**		



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

Sin deuda financiera, sin covenants ni pensiones de prestación definida. Pasivos por arrendamiento de 2,2 M [1]. Ingresos diferidos (cobros por adelantado) de 65,3 M, un 35 % más que en FY2025: es circulante que se compensa con servicio, no deuda [1]. Pasivo por impuesto diferido de 62,7 M, casi todo por la plusvalía no realizada de 4D Medical [1]. Activos financieros no corrientes de 189,4 M: el préstamo convertible de 4D Medical (182,0 M a 30-jun-2026; 149,1 M con la cotización del 17-ago-2026), que vence en julio-agosto de 2027 y se liquida con 12,5-20 M en caja más acciones de 4D Medical, y 7,3 M en acciones preferentes de Elucid [1]. Compromiso posterior al cierre: notas convertibles de Echo IQ por 10 M (otros 10 M si la FDA aprobaba EchoSolv HF, lo que no ocurrió el 10-sep-2026) [1, 99].

12. Asignación de capital

Confianza: Alta

Pro Medicus reparte ~50 % del beneficio subyacente en dividendo totalmente franqueado: 69 c en FY2026 (32 c a cuenta y 37 c final), +25,5 % [1, 11]. Recompra en el mercado cada año desde 2022, pero pequeñas: 10,1 M en FY2026 (hasta el 10 % del capital autorizado; 48.524 acciones a 190-262 AUD en el programa que terminó el 31-mar-2026) [14]. Prioridades declaradas: financiar el crecimiento orgánico, devolver capital con prudencia y mantener liquidez; compras «muy selectivas» [11, 12]. Sin deuda y sin intención de tomarla.

Periodo	FCF	Adquisiciones	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
FY2017	9	0	3	0	1	34 %	104,1
FY2018	7	0	5	0	0	40 %	104,3
FY2019	17	0	10	0	0	51 %	104,4
FY2020	23	0	11	1	0	51 %	104,5
FY2021	31	0	14	0	0	44 %	104,6
FY2022	52	0	19	4	0	51 %	104,6
FY2023	56	0	26	1	0	44 %	104,6
FY2024	75	0	37	3	0	47 %	104,7
FY2025	103	0	49	8	0	49 %	104,7
FY2026	118	0	65	10	0	28 %	104,7



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2024	Elucid Bioimaging Inc. (EE. UU., IA para TC cardiaca): 2.577.718 acciones preferentes serie C	7	Caja (USD 5,0 M)	Nivel 3, mantenida a 7,336 M a 30-jun-26, sin cambios de valor [1, 2].
2026	4D Medical (4DX): préstamo garantizado de 10 M a 2 años (vence 31-jul/14-ago-2027) con pago de 12,5-20 M y acciones adicionales según la cotización	10	Caja	Valor razonable 182,0 M a 30-jun-26 (ganancia no realizada 172,0 M); 149,1 M con la cotización del 17-ago-2026 [1].
2026	EchoIQ: nota convertible de 10 M al 12,5 % (otros 10 M si la FDA aprueba EchoSolv HF) y acuerdo de reventa	10	Caja (sin desembolsar a 30-jun-26)	Ganancia de 2,354 M por el derecho de suscripción en FY26; contrato principal firmado el 14-ago-2026 [1].

La asignación de capital ha sido excelente en lo esencial: 491 M de flujo libre acumulado en FY2017-FY2026, de los que 238 M fueron a dividendos y 27 M a recompras, sin una sola compra desde Visage en 2009 (pagada con caja) y con un ROIC incremental del 113 %. La duda nueva son las apuestas pequeñas en empresas cotizadas de IA médica (4D Medical, Echo IQ, Elucid): poco dinero (unos 37 M comprometidos), pero ruido contable y un riesgo de distracción; Echo IQ cayó tras el rechazo de la FDA en septiembre [99]. Las recompras a 190-262 AUD en 2025-2026 se hicieron muy por encima de nuestro valor. Tampoco hay dilución (104,7 M de acciones diluidas, casi las mismas que en 2017).

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Alta

Nombre	Cargo	Desde	% capital	Trayectoria y resultados
Dr Sam Hupert	Cofundador, consejero delegado (Managing Director y CEO)	1983	23,16 %	Médico (Monash), cofundó Pro Medicus en 1983 y fue CEO hasta octubre de 2007; volvió al cargo en octubre de 2010 [1]. En su etapa los ingresos han pasado de 93,5 M en FY22 a 261,7 M en FY26 y el BPA subyacente ha crecido un 34 % anual en FY24-FY26 [1]. 24.196.660 acciones a 30-jun-2026 (23,16 %) [1].
Anthony Hall	Cofundador, consejero ejecutivo y director de tecnología (Technology Director)	1983	23,14 %	Cofundador en 1983 y arquitecto principal del software de Visage RIS; licenciado y máster en ciencias por La Trobe [1]. 24.174.166 acciones a 30-jun-2026 (23,14 %) [1].
Danny English	Directora financiera (CFO) y secretaria del consejo	2026	0,00 %	En la empresa desde marzo de 2015 (Group Financial Controller, luego Head of Finance y secretaria del consejo); CFO desde el 16-mar-2026 en sustitución de Clayton Hatch, CFO desde junio de 2012 [1, 52]. 1.428 acciones [1].
Peter Kempen	Presidente no ejecutivo (independiente según el consejo)	2008	0,60 %	Consejero desde el 12-mar-2008 y presidente desde agosto de 2010; ex socio director de Ernst & Young Corporate Finance Australia y expresidente de Patties Foods [1]. 630.082 acciones (0,60 %) [1, 46].
Dr Malte Westerhoff	Director general de Europa (Visage Imaging GmbH) y CTO global	2009	0,08 %	Cofundador de Indeed - Visual Concepts, precursora de Visage Imaging; responsable de producto e I+D global; antes en Mercury Computer Systems [1]. Único directivo con KPI individual en el LTI; 87.099 acciones a 30-jun-2026 [1].
Sean Lambright	Jefe global de ventas y VP de ventas de Norteamérica (Visage Imaging)	2010	–	En Visage desde 2010; antes en AGFA Healthcare, AMICAS y Emageon [1]. Responsable de las ventas en EE. UU.: 10 contratos nuevos por 407 M mínimos en FY26 [10].
Tim Kern	Director de estrategia (Chief Strategy Officer)	2025	–	Entró en octubre de 2025; casi 10 años en Resmed (director general de MEDIFOX DAN), antes TPG Capital, Hg Capital y McKinsey [1]. Lleva estrategia, inversiones y alianzas (4DMedical, Echo IQ) [1].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
FY2023	Objetivo interno del bonus (STI), publicado a posteriori: EBIT subyacente 75,8 M (+25 % sobre FY22); valor anual de contratos nuevos (ACV) 23,4 M [61]	EBIT subyacente 80,7 M; ACV 14,5 M [61]	Parcial
FY2024	Objetivo del STI: EBIT subyacente 111,4 M (+36 % sobre FY23); ingresos subyacentes 152,0 M (+21,7 %) [2]	EBIT subyacente 105,01 M (5,39 % por debajo); ingresos 152,5 M (+23,1 %) [2]	Parcial
FY2025	Objetivo del STI: EBIT subyacente 147,5 M; ingresos subyacentes 196,5 M [60]	EBIT subyacente 152,4 M; ingresos 206,3 M; pago del STI del 139-146 % del objetivo [1, 60]	Sí
FY2026	Declarado por el CEO: «aiming for 30% increases in EBIT and NPAT» [10]. Objetivo del STI: EBIT subyacente 210,0 M (+37,9 % sobre FY25) e ingresos subyacentes 259,2 M [1]	En moneda constante EBIT 206,0 M (+30,6 %) y beneficio neto 154,5 M (+32,5 %); reportado EBIT 196,1 M (+24,4 %) y beneficio neto subyacente 144,7 M (+24,1 %) [10]. Base del STI: EBIT 199,5 M, por debajo del umbral (pago nulo en ese tramo), e ingresos 266,6 M (pago del 151,4 %) [1]	Parcial

La dirección es la de siempre: Sam Hupert y Anthony Hall fundaron la empresa en 1983 y siguen como consejero delegado y director técnico, con el 23,2 % del capital cada uno [1]. Su credibilidad es alta en lo que controlan (contratos, margen, renovaciones del 100 %), pero la empresa no da guía numérica y en FY2026 el objetivo de +30 % de EBIT solo se cumplió en moneda constante [10]. La estabilidad se ha roto un poco en 2026: el director financiero de casi 14 años se fue en marzo (le sustituye una promoción interna) y el jefe de operaciones y relaciones con inversores en mayo [52, 53]. No hay plan de sucesión público para Hupert; es el principal riesgo de equipo, porque las ventas a los grandes hospitales de EE. UU. dependen en buena parte de él y de Malte Westerhoff (técnico, Berlín).

14. Gobierno corporativo

Confianza: Alta

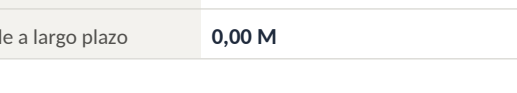
Consejeros	**8**	Independientes	**75 %**
Antigüedad media en el consejo	**16,8 años**	Criterios de buen gobierno cumplidos	**12 de 13 (1 sin dato)**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**0**		

Consejero	Cargo	Tipo	Desde	Comisiones
Peter Kempen	Presidente no ejecutivo	Independiente	2008	Auditoría y Riesgos
Dr Sam Hupert	Consejero delegado y CEO; cofundador (23,16 %)	Ejecutivo	1983	Ninguna
Anthony Hall	Consejero ejecutivo y director de tecnología; cofundador (23,14 %)	Ejecutivo	1983	Ninguna
Anthony Glenning	Consejero no ejecutivo	Independiente	2016	Auditoría y Riesgos; Personas y Cultura
Dr Leigh Farrell	Consejero no ejecutivo	Independiente	2017	Auditoría y Riesgos; Personas y Cultura
Deena Shiff	Consejera no ejecutiva	Independiente	2020	Preside Personas y Cultura (remuneración y nombramientos); Auditoría y Riesgos
Alice Williams	Consejera no ejecutiva	Independiente	2021	Preside Auditoría y Riesgos; Personas y Cultura
Tim Reed	Consejero no ejecutivo (desde el 1-oct-2026)	Independiente	2026	Sin asignar aún

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	75 % (con control)	Cumple
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Independiente del control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	No ejecutivo	Cumple
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Ninguno	Cumple
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	0 cambios	Cumple
Peor voto en contra sobre remuneración (3 juntas, capital libre) ≤ 20 %	17,6 % en contra	Cumple
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	Sí	Cumple
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	Sin dato	Sin dato
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Compras 5,98 / ventas 0,00 M	Cumple

Accionariado

Accionista	% capital	Tipo	Movimientos recientes
Dr Sam Hupert (directa e indirecta: Alltogether Superannuation Fund, Sam Hupert Family Trust)	23,16 %	Fundador y CEO	+59.000 acciones en FY26 (50.000 heredadas el 3-sep-2025 y 9.000 compradas en dic-2025 y feb-2026) [1, 39, 40, 47, 51]; vendió 1 M de acciones en mar-2023, nov-2023 y dic-2024 [33]
Anthony Hall	23,14 %	Fundador y consejero ejecutivo	+30.166 acciones compradas en dic-2025 y feb-2026 [1, 41, 42, 48, 49, 50]; vendió 1 M de acciones en mar-2023, nov-2023 y dic-2024 [33]
AustralianSuper Pty Ltd	5,01 %	Fondo de pensiones australiano	Pasó a accionista significativo el 27-may-2026 con 5.237.486 acciones; sin aviso posterior de salida hasta el corte [33, 57]
State Street Corporation y filiales	–	Gestora (fondos indexados)	Entró el 9-abr-2026 con 5.237.341 acciones (5,01 %) y bajó del 5 % el 3-sep-2026 [56, 58]
Peter Kempen (con Elaine Kempen)	0,60 %	Presidente	+1.000 acciones en FY26 [1, 43, 46]
Autocartera (Employee Share Trust)	–	Acciones para los planes de empleados	La recompra en el mercado (48.524 acciones por 11,6 M) terminó el 31-mar-2026 y las acciones se amortizaron; el trust de empleados entrega acciones por los derechos ejercidos, sin saldo publicado [1]



Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

Fecha	Persona	Operación	Acciones	Importe (M)
22 dic 2025	Sam Hupert (CEO) [39]	Compra	2.250	0,50
23 dic 2025	Sam Hupert (CEO) [40]	Compra	2.250	0,50
22 dic 2025	Anthony Hall (consejero ejecutivo) [41]	Compra	2.250	0,50
23 dic 2025	Anthony Hall (consejero ejecutivo) [42]	Compra	2.270	0,50
29 dic 2025	Peter Kempen (presidente) [43]	Compra	600	0,13
13 feb 2026	Deena Shiff (consejera independiente) [44]	Compra	788	0,10
13 feb 2026	Anthony Glenning (consejero independiente) [45]	Compra	2.080	0,25
23 feb 2026	Peter Kempen (presidente) [46]	Compra	400	0,05
24 feb 2026	Sam Hupert (CEO) [47]	Compra	4.500	0,49
24 feb 2026	Anthony Hall (consejero ejecutivo) [48]	Compra	8.500	0,94
25 feb 2026	Anthony Hall (consejero ejecutivo) [49]	Compra	9.000	1,03
26 feb 2026	Anthony Hall (consejero ejecutivo) [50]	Compra	8.146	0,99

Remuneración

Remuneración total del primer ejecutivo (FY2026)	**1,07 M**	Fijo	**1,07 M**
Variable anual	**0,00 M**	Variable a largo plazo	**0,00 M**

Peor voto a favor (3 juntas)	**82,4 %**	Peor voto en contra (3 juntas)	**17,6 %**
Ratio sobre salario medio	**3x**		

Los fundadores solo cobran fijo: Hupert, 1,07 M AUD en FY2026, unas 3,1 veces el coste medio por empleado (estimación propia), sin bonus ni acciones [1]. Para el resto de directivos clave, el variable anual pesa hasta el 50 % del fijo y depende del EBIT subyacente (35-40 %), de los ingresos (30-35 %) y de objetivos individuales; en FY2026 el EBIT (199,5 M) quedó por debajo del umbral de 210,0 M y no pagó, y los ingresos sí (151,4 %) [1]. El variable a largo plazo mide BPA subyacente (sin divisas ni plusvalías) y TSR relativo al S&P/ASX 100 en tres años. Hay malus pero no recuperación de lo pagado. El voto en contra del informe de remuneración fue del 17,62 % en 2023 y bajó al 2,86 % y 3,91 % en 2024 y 2025, sin «strike» [36, 37, 38].

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

Hupert (23,16 %) y Hall (23,14 %) suman el 46,3 % del capital. No hay pacto declarado, pero son socios desde 1983, consejeros ejecutivos ambos y dueños de la sociedad que alquila la sede a la empresa; en la junta de 2025 sus acciones serían ~55,6 % de los votos emitidos (estimación propia): de hecho controlan la junta [1, 36]. El presidente, Peter Kempen, es independiente según el consejo pese a sus 18 años en él [34]. Una acción, un voto; sin blindajes. La operación vinculada es menor: 215.120 AUD al año de alquiler a Champagne Properties, en condiciones de mercado según la empresa [1]. El voto de remuneración excluye a los directivos clave, así que mide al capital libre.

Señales de alerta

- Rotación de la dirección financiera: el CFO de casi 14 años (Clayton Hatch) dejó el cargo el 16-mar-2026 y la empresa en agosto de 2026; le sustituye una promoción interna (Danny English) [1, 52, 53].
- Alquiler de la sede (450 Swan Street, Richmond) a Champagne Properties Pty Ltd, sociedad controlada por Hupert y Hall: 215.120 AUD al año en FY25 y FY26, en condiciones de mercado según una valoración independiente [1].
- No hay función de auditoría interna (ni externalizada); el consejo lo revisa a medida que crece la empresa [34, 35].
- Presidente con 18 años en el consejo y el 0,60 % del capital; el consejo lo declara independiente pese a la antigüedad [34].
- Incidente de ciberseguridad (jul-2025, comunicado el 4-dic-2025 tras rumores): acceso a un buzón de correo con datos personales de unos 100 empleados; sin acceso a sistemas de clientes ni pérdidas, según la empresa [62].
- Auditor: Ernst & Young, sin cambios; honorarios de otros servicios de EY Australia de 15.936 AUD frente a 529.423 de auditoría [1].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

Pro Medicus no publica guía numérica. Para FY2026 el CEO dijo que apuntaban a crecer un 30 % en EBIT y beneficio neto, y lo cumplieron solo en moneda constante (+30,6 % y +32,5 %) [10]. Para FY2027 (18-ago-2026) solo dice que tendrá doce meses completos de las implantaciones de FY2026 (Trinity, UC Health Colorado, BayCare, Beth Israel Lahey) y que el contratado mínimo a cinco años es de 1.340 M (+41 %) [6, 12]. No hay plan a medio plazo con cifras; el objetivo de BPA del plan de acciones de los directivos (+25,6 % anual en FY2026-FY2028) es la referencia interna más concreta [1].

Periodo	Ingresos	EBITDA	EBIT	BPA	DPA	Fuente
FY2027e	339	267	258	1,79	0,94	MarketScreener, consenso a 12-oct-2026 (15 analistas) [69]; Stock Analysis (S&P Global, 14 analistas FY27): ingresos 338,7 M (rango 321,5-354,8), BPA 1,83 (1,72-1,88) [71]
FY2028e	420	333	323	2,29	1,14	MarketScreener, consenso a 12-oct-2026 [69]
FY2029e	509	406	394	2,76	1,37	MarketScreener, consenso a 12-oct-2026 [69]

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	Ingresos consenso	Dif.	EBITDA propio	EBITDA consenso	Dif.
FY2027e	330	339	-2,6 %	259	267	-2,9 %
FY2028e	406	420	-3,3 %	320	333	-3,9 %
FY2029e	491	509	-3,5 %	390	406	-3,9 %

Analistas	**15**	Comprar / mantener / vender	**9 / 5 / 1**
Precio objetivo medio	**202,47**	Rango de precios objetivo	**60,00 – 250,00**

Revisiones de estimaciones

No hay historial gratuito de revisiones de estimaciones (registrado como hueco). Lo observable: tras los resultados de FY2026, dos analistas pasaron de comprar a mantener (de 12 compras y 2 mantener en junio a 9 y 5 en septiembre) [71], y el precio objetivo medio (202,47 AUD) está muy por debajo del precio de hace un año (300 AUD) [66, 70]. El consenso de FY2027 (ingresos 338,7 M, +29,4 %) sigue suponiendo que el ritmo en moneda local se mantiene pese a un AUD más fuerte; el rango de ingresos de Stock Analysis (321,5-354,8 M) es estrecho [71].

16. Comportamiento en bolsa

Confianza: Media

Rentabilidad total (con dividendos).

Periodo	Acción	Índice	Sector
En el año	-23,4 %	+3,6 %	+2,1 %
1 año	-44,6 %	+1,5 %	+6,9 %
3 años (anual.)	+26,7 %	+11,0 %	+5,5 %
5 años (anual.)	+27,0 %	+7,7 %	+6,9 %
10 años (anual.)	+41,6 %	+8,9 %	+10,0 %



Beta (5 años, mensual)	**1,58**	Volatilidad anualizada (1 año)	**55,1 %**
Máxima caída (5 años)	**-67,2 %**	Posiciones cortas	**3,9 %**

La acción multiplicó por 31 su precio en diez años (41,6 % anual) y llegó a 300 AUD en octubre de 2025, a más de 200 veces el beneficio [66]. Desde ahí ha perdido el 44,6 % en un año y llegó a caer un 67,2 % hasta febrero de 2026. Tres causas: la venta general de software por el miedo a la IA desde finales de 2025 [93], el semestre de febrero (−23,9 % el día de resultados, con un crecimiento del 28 % que el mercado consideró insuficiente para el múltiplo) y la salida de índices y fondos (State Street bajó del 5 % en septiembre) [58, 66]. Desde el mínimo de 107,75 AUD ha subido un 56 %. La beta (1,58 mensual a 5 años) y la volatilidad del 55,1 % son de valor de crecimiento, no de empresa sanitaria. La posición corta es del 3,94 % del capital (6-oct-2026), alta para un valor del ASX 50 [59].

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Media

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	84,6x	78,1x	28,8x	179,6x	60 %	+8 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	121,7x	116,5x	59,1x	258,9x	60 %	+5 %

Al cierre de cada ejercicio, el EV/EBITDA de los últimos 12 meses fue de 78,1x de media en diez años; hoy es 84,6x, en el percentil 60. Pro Medicus siempre ha cotizado caro y el mercado lo ha mantenido mientras crecía al 25-35 %. Lo que ha cambiado es que el crecimiento reportado baja del 30 % al 23 % y los tipos australianos a 10 años están en el 5,4 %, frente al 1-2 % de 2019-2021 [67]. El PER histórico de FY2026 sale bajo porque usa el beneficio estatutario con las plusvalías; sobre el subyacente la acción cotiza a ~122 veces los últimos 12 meses y a 87,0 veces los próximos.

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Software vertical de alto margen y alto crecimiento: Sectra (el competidor directo cotizado más puro en PACS), Veeva y Doximity (software para el sector sanitario de EE. UU.), Craneware (software para hospitales de EE. UU.), y cuatro compañías de software «de calidad» de Australasia y Europa con las que compite por el capital de los inversores (WiseTech, Xero, TechnologyOne, Nemetschek) [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80]. Fuera: GE HealthCare, Philips y Fujifilm (fabricantes de equipos con márgenes del 10 %), CompuGroup y Nexus (excluidas de bolsa tras OPA) y Tempus AI (EBITDA negativo).

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	EV/ EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
Pro Medicus	AU	17.622	66,0x	84,6x	60,5x	87,0x	+28,7 %	78,0 %	110,5 %	-1,2x	0,7 %
Sectra	SE	8.584	15,2x	62,0x	49,9x	72,5x	+16,9 %	23,5 %	–	-1,9x	1,2 %
Veeva Systems	US	70.071	12,0x	26,3x	23,3x	41,7x	+13,1 %	45,6 %	–	-4,1x	3,2 %
Doximity	US	8.579	7,9x	15,5x	15,5x	40,3x	+5,9 %	55,5 %	–	-2,2x	4,9 %
Craneware	GB	711	2,4x	7,8x	9,7x	51,5x	-7,5 %	32,6 %	–	-0,1x	5,2 %
WiseTech Global	AU	11.482	6,9x	16,2x	12,9x	25,4x	+8,0 %	40,0 %	–	3,0x	4,6 %
Xero	NZ	10.695	4,2x	16,2x	13,0x	42,1x	+25,8 %	27,5 %	–	0,2x	3,7 %
TechnologyOne	AU	10.248	14,6x	32,7x	27,7x	51,2x	+15,5 %	44,4 %	–	-1,0x	1,6 %
Nemetschek	DE	12.479	5,8x	18,6x	14,7x	26,6x	+20,9 %	31,2 %	–	0,4x	4,9 %

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	EV/Vtas	EV/EBITDA LTM	EV/EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA
Mediana	7,4x	17,4x	15,1x	41,9x	+14,3 %	36,3 %
Media	8,6x	24,4x	20,8x	43,9x	+12,3 %	37,5 %
Percentil 25	5,4x	16,0x	13,0x	36,9x	+7,5 %	30,3 %
Percentil 75	12,6x	27,9x	24,4x	51,3x	+17,9 %	44,7 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
EV/EBITDA próximos 12 meses	286	13,0x / 15,1x / 24,4x	38,66	44,46	69,84	-73,6 %
EV/EBITDA últimos 12 meses	204	16,0x / 17,4x / 27,9x	34,51	37,20	57,68	-77,9 %
PER próximos 12 meses	1,9	36,9x / 41,9x / 51,3x	71,34	81,06	99,20	-51,9 %
EV/Ventas últimos 12 meses	262	5,4x / 7,4x / 12,6x	16,69	21,79	34,78	-87,1 %



Regresión EV/EBITDA NTM sobre crecimiento (8 comparables): múltiplo = 16,0 + 0,39 × crecimiento; R^2 = 0,09. El crecimiento explica poco los múltiplos de estos comparables (R^2 < 0,3): la regresión no se usa en la valoración.

Pro Medicus es un caso aparte en el mapa: su margen EBITDA (78 %) duplica la mediana de los comparables (36,3 %) y su crecimiento esperado está en lo alto del grupo, pero su EV/EBITDA de los próximos 12 meses (60,5x) cuadruplica la mediana (15,1x) y su PER (87,0x) dobla la mediana (41,9x). Ni siquiera Sectra, el competidor directo, que cotiza a 49,9x y crece un 16,9 %, se le acerca. Aplicando las medianas el valor sale entre 44,46 (EV/EBITDA) y 81,06 AUD (PER) por acción; con el percentil 75, entre 69,84 y 99,20. La prima se justifica en parte por el margen y el ROIC, pero un múltiplo de 60x sobre el EBITDA solo se paga si el crecimiento dura más de una década. Usamos el EV/EBITDA, con PER como contraste, y la regresión no explica nada (R^2 = 0,09).

19. Transacciones precedentes

Confianza: Media

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2021-04	Nuance Communications (IA clínica y dictado; PowerScribe en radiología)	Microsoft	28.220	15,30x	–	23 %	Valor empresa de 19.700 M USD con la deuda neta [82]; ventas FY2020 de 1.283,8 M USD [83]; EBITDA no significativo.
2021-08	Inovalon (datos y software para aseguradoras y proveedores)	Nordic Capital e Insight Partners	10.457	10,90x	39,1x	25 %	Valor empresa ~7.300 M USD [86]; EBITDA contable 2020 de 186,6 M USD [87] (estimación propia del múltiplo).
2021-12	Cerner (historia clínica electrónica)	Oracle	42.050	5,30x	18,2x	–	Valor empresa estimado de 29.354 M USD [84, 85]; EBITDA contable 2020 de 1.612 M USD [85] (estimación propia).
2023-12	Volpara Health Technologies (IA para imagen mamaria, ASX)	Lunit	286	7,50x	–	47 %	7,5 veces las ventas FY24, múltiplo publicado por el vendedor [88]; con pérdidas operativas.
2024-12	CompuGroup Medical (software para médicos y hospitales)	CVC Capital Partners	–	–	–	34 %	Oferta de 22,00 EUR por acción; prima del 33,5 % [89]. Sin valor empresa ni múltiplo publicados.
2026-03	Intelerad (PACS y visor de imagen médica)	GE HealthCare	3.295	8,50x	–	–	2.300 M USD por ~270 M USD de ingresos del primer año, ~90 % recurrentes y margen EBITDA superior al 30 % [27] (múltiplo de ventas, cálculo propio). Es el competidor directo más parecido.

		Prima de control mediana	**29 %**
Valor por acción implícito (mediana de EV/ventas)	**24,51**	Rango p25 – p75	**22,00 – 30,51**



Ninguna operación es un buen espejo: las de software sanitario se pagaron a 5-15 veces las ventas y 18-39 veces el EBITDA, frente a 66 veces las ventas y 85 veces el EBITDA a las que cotiza hoy Pro Medicus. La más cercana es la compra de Intelerad, competidor directo en PACS, por GE HealthCare en marzo de 2026: unas 8,5 veces los ingresos [27]. Una OPA sobre Pro Medicus es improbable: los fundadores controlan el 46,3 % y el tamaño (17.622 M de capitalización) solo está al alcance de GE HealthCare, Siemens Healthineers, Philips u Oracle. Las transacciones no pesan en el valor objetivo.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Media

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

Partimos de 26 % en FY2027e: doce meses completos de Trinity (5 de 7 cohortes implantadas), UC Health Colorado, BayCare y Beth Israel Lahey, más la base de clientes creciendo ~8 % en estudios [6, 12], menos ~2,5 puntos por un AUD más fuerte (0,698 USD frente a 0,678 de media en FY2026). Es un 2,6 % menos que el consenso en ingresos de FY2027 y un 3,5 % menos en FY2029 [69]. Después bajamos dos puntos al año hasta el 7 % de FY2036e: 16,1 % anual de media en diez años, frente al 26,5 % de los últimos nueve. Los ingresos de FY2036e (1.149 M) multiplican por 4,4 los de hoy.

Márgenes.

El margen EBITDA sube de 78,0 % a 80 % en FY2030e y se queda ahí. El historial lo apoya: +19,6 puntos en nueve años con 153 empleados, cada contrato nuevo apenas añade coste y el consenso prevé un EBIT del 76-77,5 % [69]. No suponemos más porque los precios de renovación suben poco y la empresa invierte en cardiología, patología e IA. Ningún competidor gana más del 25 % de EBIT [18, 19], así que un margen del 80 % ya es el máximo del sector.

Inversión y circulante.

Capex del 4,4 % de las ventas en FY2027e bajando al 3,3 %: desarrollo activado (~3 %, como en FY2017-FY2026) más el aumento de las comisiones de venta activadas (2,4 % de las ventas en FY2026, que se normaliza con la contratación) [1]. Amortización del 3,1 % (como en FY2026). Circulante del 5 % de las ventas (6,8 % en FY2026, −15 % a −2 % en FY2019-FY2024), por los clientes que crecen más que las ventas. Impuesto del 30 % (29,7 % en FY2026).

Coste del capital.

Tasa libre: bono australiano a 10 años del 5,40 % (7-oct-2026, tabla F2 del RBA) [67]. Beta 1,25: entre la semanal de 2 años (1,19) y la sectorial de software de Damodaran corregida por caja (1,25) [66, 90]; la mensual de 5 años (1,58; 1,39 ajustada) recoge la burbuja y caída de 2025-26 y daría un 13,0 %. Prima de mercado del 5,5 %, sin prima adicional (empresa sin deuda, ingresos en EE. UU.). WACC = coste de capital = 12,28 %. Con la prima implícita de Damodaran (4,20 % [68]) sería el 10,65 %; el motor da también ese caso.

Valor terminal.

Crecimiento a perpetuidad del 3,0 %: entre la inflación objetivo del RBA (2-3 %) y la tasa libre menos medio punto (4,9 %), coherente con flujos en AUD de un negocio que a esas alturas tendría ~30 % de su mercado. El valor terminal pesa el 35 % del valor (más la transición, el 54 %). El múltiplo implícito de salida es 7,4 veces el EBITDA: bajo frente al actual porque el negocio crecería ya al 3 %.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,40 %
Beta	1,25
Prima de riesgo de mercado	5,50 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,00 %
Coste de los fondos propios	12,28 %
Coste de la deuda antes de impuestos	5,90 %
Tipo impositivo	30,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	4,13 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	0,00 %
WACC	12,28 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	10,65 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
FY2027e	330	26,0 %	259	78,5 %	10	75	15	-1	171	0,71	117
FY2028e	406	23,0 %	320	79,0 %	13	92	17	4	207	1,00	180
FY2029e	491	21,0 %	390	79,5 %	15	112	20	4	254	1,00	196
FY2030e	584	19,0 %	467	80,0 %	18	135	23	5	305	1,00	210
FY2031e	683	17,0 %	547	80,0 %	21	158	26	5	358	1,00	220
FY2032e	786	15,0 %	629	80,0 %	24	181	29	5	413	1,00	226
FY2033e	888	13,0 %	710	80,0 %	28	205	32	5	468	1,00	228
FY2034e	986	11,0 %	788	80,0 %	31	227	34	5	522	1,00	226
FY2035e	1.074	9,0 %	859	80,0 %	33	248	37	4	571	1,00	220
FY2036e	1.149	7,0 %	920	80,0 %	36	265	38	4	613	1,00	211

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.



Etapa de transición (DCF en tres etapas)

Con la etapa de transición de 5 años el DCF da 45,92 por acción; sin ella (crecimiento terminal desde FY2036e), 43,79.

Año	Ingresos	Crec.	M. EBITDA	Capex	FCFF	Factor	VA
FY2037e	1.221	6,2 %	80,0 %	40	651	0,306	200
FY2038e	1.287	5,4 %	80,0 %	42	687	0,273	188
FY2039e	1.346	4,6 %	80,0 %	43	720	0,243	175
FY2040e	1.397	3,8 %	80,0 %	45	748	0,216	162
FY2041e	1.439	3,0 %	80,0 %	46	771	0,193	149

Entre la proyección explícita y el valor terminal, el crecimiento baja en línea recta hasta el terminal; el margen y los ratios son los del último año explícito, y la inversión neta (capex − amortización) se reduce en proporción al crecimiento.

Por qué el crecimiento dura más allá de la proyección.

Pro Medicus tiene ~11 % de los estudios de imagen de EE. UU. [6], firma contratos a 5-10 años con renovaciones del 100 % y precio por estudio más alto [1], y su ROIC (más del 100 %) supera el WACC en más de 90 puntos. El contratado mínimo a cinco años (1.340 M) ya cubre buena parte de los ingresos de FY2027-FY2031 [6]. Además entra en cardiología y patología digital, mercados nuevos [1]. Por eso dejamos una transición de cinco años desde el 7 % de FY2036e hasta el 3 % terminal, en vez de cortar en seco. Aporta el 4,9 % del valor (43,79 AUD sin ella).

Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Crecimiento a perpetuidad
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	25,0x
Valor terminal (Gordon)	8.564
Valor terminal (múltiplo)	28.777
Múltiplo de salida implícito en Gordon	7,4x
Crecimiento implícito en el múltiplo	9,34 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	35 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	2.034
Valor actual de la etapa de transición (5 años)	873
Valor actual del valor terminal	1.559
Valor empresa	4.465
− Deuda financiera neta (con arrendamientos)	250
− Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	90
Valor de los fondos propios	4.806
Acciones diluidas (millones)	104,7
Valor por acción	45,92



Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
11,3 %	49,14	50,45	51,92	53,58	55,47
11,8 %	46,37	47,49	48,74	50,14	51,72
12,3 %	43,88	44,85	45,92	47,11	48,44
12,8 %	41,64	42,48	43,40	44,42	45,55
13,3 %	39,61	40,33	41,13	42,01	42,98

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	38,78	41,66	44,79	48,19	51,89
-1 pp	39,26	42,18	45,36	48,80	52,55
0 pp	39,74	42,70	45,92	49,41	53,21
+1 pp	40,22	43,22	46,48	50,02	53,87
+2 pp	40,71	43,74	47,04	50,63	54,53

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: En parte.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	16,1 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	3,8 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	82 M (2 % del NOPAT)
Cuota de mercado implícita en FY2036e	31,1 % (hoy: 11,0 %)

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 82 M, el 2 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 3,8 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del 16,1 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la cuota (31,1 % del mercado en FY2036e, frente al 11,0 % de hoy); en un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
FY2027e	+25,5 %	+3,0 %	-2,5 %	+26,0 %	Volumen: año completo de Trinity, UC Health, BayCare y BILH más ~8 % de estudios en los clientes actuales [6, 12]. Precio: renovaciones de FY2026 con tarifa por estudio más alta [1]. Otros: AUD más fuerte frente al USD (estimación propia).
FY2028e	+20,5 %	+2,5 %	0,0 %	+23,0 %	Volumen: contratos de FY2026-FY2027 (Radiology Associates of North Texas, Valley Health, St Luke's) y crecimiento de estudios de los clientes [1, 33]. Precio: renovaciones al alza.
FY2029e	+18,5 %	+2,5 %	0,0 %	+21,0 %	Volumen: cuota de EE. UU. de ~15 % (+2 puntos al año, como en 2024-2026 [6]) y cardiología. Precio: ~2,5 % anual (estimación propia).
FY2030e	+16,5 %	+2,5 %	0,0 %	+19,0 %	Volumen: ganancia de cuota y patología digital, aún incipiente [1]. Precio: ~2,5 %.
FY2031e	+14,5 %	+2,5 %	0,0 %	+17,0 %	Volumen: cuota de EE. UU. ~20 % y estudios del mercado +3 % [6]. Precio: ~2,5 %.

En parte. La calidad es indiscutible: margen EBIT del 75 %, ROIC por encima del 100 %, renovaciones del 100 % con precio más alto y 1.340 M de ingresos mínimos contratados a cinco años [1, 6]; el crecimiento no necesita capital (reinversión del 2 % del beneficio operativo). La prueba que falla es la cuota: nuestro caso base, que ya es exigente (16,1 % anual en diez años), lleva a Pro Medicus del 11 % al ~31 % de los estudios de EE. UU. (al ingreso por estudio de PME, ~3,1 AUD, el mercado sería de unos 3.700 M en FY2036e), y eso supone ganar unos 2 puntos al año durante una década frente a GE HealthCare-Intelerad, Sectra, Philips o Fujifilm. El precio por estudio no ha subido de forma visible: unos 3,1 AUD en FY2024 y en FY2026 (estimación propia) [6]. El precio actual pide mucho más: un crecimiento del 33,0 % anual en diez años, unos ingresos superiores a todo el mercado de EE. UU.

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

Crecimiento anual implícito en el precio (FY2027e-FY2036e)	**33,0 % (base: 16,1 %)**
Margen EBITDA final implícito	**n.d.ningún margen hasta el 110 % justifica el precio (base: 80,0 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**5,7 % (WACC: 12,3 %)**

El DCF da 45,92 AUD por acción frente a 168,37 de precio (−72,7 %), con el valor terminal en el 35 % del valor. El DCF inverso es la clave: para justificar el precio con nuestros márgenes (80 %) y nuestro WACC, Pro Medicus tendría que crecer un 33,0 % anual durante diez años, frente al 16,1 % de nuestro caso base y al 26,5 % de los últimos nueve años. Unos ingresos que crecen al 33 % durante diez años llegarían a unos 4.500 M en FY2036, más que todo el mercado de imagen de EE. UU. valorado a su precio por estudio (~3.700 M): no basta con ganar cuota, haría falta cardiología, patología y otros países al mismo ritmo. Dicho de otro modo, quien compra hoy a 168,37 con nuestras cifras obtiene una rentabilidad anual del 5,7 %, igual que el bono australiano (5,40 %). Ningún margen alcanza: con el 80 % ya suponemos el máximo del sector. Con la prima implícita del mercado (WACC del 10,65 %) el DCF sube a 56,51 AUD, aún un 66 % por debajo del precio. Coincidimos con el consenso en los tres próximos años (−2,6 % a −3,5 % en ingresos): la diferencia está en lo que el precio supone para la década siguiente.

21. Escenarios

Confianza: Media

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	10,1 %	75,0 %	12,3 %	27,75	-83,5 %	La IA generativa y los grandes fabricantes (GE HealthCare con Intelerad, Philips) abaratan el visor y el archivo; las renovaciones de 2027-2029 se firman sin subida de tarifa y la ganancia de cuota se frena en el ~18 %. El crecimiento baja 6 puntos cada año y el margen 5 puntos por más gasto comercial e I+D, como le pasó a Sectra al pasar a la nube.
Base	50 %	16,1 %	80,0 %	12,3 %	45,92	-72,7 %	Pro Medicus sigue ganando unos 2 puntos de cuota al año en EE. UU. hasta ~31 % de los estudios en FY2036e, con precios +2,5 % anual y margen EBITDA del 80 %. El crecimiento baja de 26 % a 7 % en diez años.
Alcista	25 %	21,1 %	81,0 %	12,3 %	69,54	-58,7 %	Cardiología, patología digital e informes con IA se suman al PACS y Europa despega; el crecimiento es 5 puntos mayor cada año (21,1 % de media en diez años) y el margen sube al 81 %. Ni siquiera así alcanza el precio: harían falta otros 12 puntos de crecimiento anual.



Valor ponderado por probabilidad: 47,28 AUD (-71,9 %).

La asimetría es completamente desfavorable: incluso el alcista (69,54 AUD, −58,7 %) queda muy por debajo del precio, y el bajista (27,75 AUD, −83,5 %) es una caída del orden de la que ya sufrió la acción entre julio de 2025 y febrero de 2026 (−67,2 %) [66]. La probabilidad del bajista (25 %) no es cosmética: el precio por estudio estimado no ha subido en dos años y Sectra muestra lo que pasa con el margen de un competidor bueno en un mercado que crece al 4 %. Con la prima del mercado el alcista vale 88,49 AUD. Para que la acción valga lo que cuesta hace falta un escenario fuera de nuestro rango: crecimiento del 33 % durante una década.

22. Suma de partes

Confianza: Alta

Un solo negocio (software de imagen médica con cobro por estudio): no hay partes con perfiles distintos.

23. Síntesis de valoración

Confianza: Media



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	107,75	168,37	300,00
Precio objetivo de los analistas	60,00	202,47	250,00
Comparables: EV/EBITDA NTM	38,66	44,46	69,84
Comparables: PER NTM	71,34	81,06	99,20
DCF (WACC y g ± 0,5)	42,48	45,92	50,14
Escenarios (bajista – alcista)	27,75	47,28	69,54
DCF con la prima del mercado	52,78	56,51	60,78
Precio actual	167,53	168,37	169,21

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	45,92	-72,7 %	40 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	62,76	-62,7 %	25 %
Transacciones precedentes (no se usa)	24,51	-85,4 %	0 %
Escenarios ponderados	47,28	-71,9 %	35 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 50,61 AUD (-69,9 % sobre 168,37).

Pesamos el DCF (40 %) y los escenarios (35 %) porque el valor de Pro Medicus depende de cuánto dure su crecimiento, y solo el DCF lo hace explícito. Los comparables (25 %) sirven de contraste: dan entre 44,46 y 81,06 AUD con las medianas y hasta 99,20 con el percentil 75 del PER, pero son empresas que crecen menos y ganan menos. Las transacciones (5-15 veces ventas) no pesan: ninguna se parece y una OPA es improbable con los fundadores en el 46,3 %. Todos los métodos dan entre 28 y 99 AUD; el precio (168,37) está fuera del rango de todos, y solo el precio objetivo de los analistas (202,47) y el rango de 52 semanas lo contienen. La dispersión entre métodos es grande, pero todos apuntan en la misma dirección.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	1,80	83,0x	base × 0.85 (el mínimo de 5 años no queda por debajo del base)	149,40	-10,9 %
Base	2,12	97,7x	PER actual	207,12	+23,4 %
Alcista	2,32	127,0x	techo de base × 1.3	294,64	+75,4 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 214,57 AUD · rentabilidad +27,8 % (base +23,4 %) · señal Mantener.

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro BPA base de 2028e (FY, jun) (2,12) se separa un -7,4 % del consenso (2,29) y nuestro precio base (207,12) un +2,3 % del objetivo medio de los analistas (202,47). No se acerca la cifra: el porqué (ventas, margen, base de BPA o múltiplo) está en el contraste con el consenso de revision-12m-2026-10-13.md.

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

Valor intrínseco 50,61 (-69,9 %) frente al objetivo a 12 meses ponderado 214,57 (+27,8 % con dividendo; base +23,4 %). La distancia pasa del 25 %: la tesis del valor intrínseco es a más de un año.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
26-oct-2026 y 25-nov-2026	Convocatoria y junta general de accionistas (posible actualización comercial)	Primer comentario sobre el arranque de FY2027 y la implantación completa de Trinity	Alta	+/−
29-nov a 3-dic-2026	Congreso RSNA (Chicago): ventana habitual de anuncios de contratos	Contratos nuevos sostienen la tesis de cuota; la falta de anuncios la debilita	Alta	+/−
Mediados de feb-2027	Resultados del 1S27	Primer semestre con Trinity, UC Health y BayCare completos; un crecimiento en AUD por debajo del 25 % repetiría la caída de febrero de 2026	Alta	+/−
Jul-ago-2027	Vencimiento del préstamo convertible de 4D Medical	Cristaliza en caja y acciones la plusvalía (169,6 M al corte); fin del ruido contable	Alta	+
2027	Renovaciones de contratos de la primera ola (2021-2022: Novant, Mayo y otros)	Miden el poder de precios: tarifa por estudio al alza o a la baja	Media	+/−
Mediados de ago-2027	Resultados de FY2027	Prueba de si el crecimiento se reacelera al 25-30 % del consenso	Alta	+/−

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Desaceleración del crecimiento por debajo de lo que exige el múltiplo**	Valoración	Alta	Alto	El precio converge al escenario base (−73 %)	Contratado mínimo a 5 años de 1.340 M (+41 %)	Crecimiento en AUD del 1S27 por debajo del 25 %
2	**Presión de precios por la IA y por competidores grandes (GE HealthCare-Intelerad, Philips, Sectra)**	Competencia	Media	Alto	Escenario bajista: −40 % sobre el valor base	Renovaciones del 100 % con tarifa más alta; nube nativa	Renovaciones sin subida de tarifa o pérdida de un cliente grande
3	**Concentración en EE. UU. y en el dólar (90,5 % de las ventas)**	Divisa	Media	Medio	Cada 5 % de apreciación del AUD resta ~4,5 % a los ingresos	Contratos largos en USD	AUD/USD por encima de 0,72
4	**Sucesión de los fundadores (Hupert y Hall, desde 1983)**	Equipo	Media	Alto	Compresión del múltiplo de 10-20 %	CTO y jefe de ventas con más de 15 años en la empresa	Anuncio de retirada o venta de acciones de los fundadores
5	**Deterioro del cobro: clientes +55,7 % con ventas +22,9 %**	Financiero	Media	Medio	Bajo en valor, alto en credibilidad	Clientes hospitalarios grandes; sin pérdidas esperadas	Vencidos a más de 90 días por encima de 10 M
6	**Inversiones en pequeñas empresas de IA (4D Medical, Echo IQ, Elucid)**	Asignación de capital	Media	Bajo	−1 a −2 AUD por acción si 4D Medical vuelve a su coste	Importes pequeños (~37 M)	Nuevas inversiones o pérdidas de valor razonable en el 1S27
7	**Ciberataque o fallo de seguridad con datos de pacientes**	Operativo	Baja	Alto	Pérdida de contratos y del argumento de calidad	SOC 2 Type II, HIPAA; sistemas en la nube de los clientes	Incidentes comunicados (hubo uno de correo en dic-2025)
8	**Salida de índices y venta de fondos tras la caída**	Mercado	Media	Medio	Volatilidad (55 % anual)	Alta liquidez (39 M AUD/día)	Posición corta por encima del 5 %

Pre-mortem

Para una recomendación de Vender, el fracaso es que la acción suba: estamos en octubre de 2029, Pro Medicus vale 300 AUD y nuestra venta fue un error. Lo que habría pasado: la nube habría hecho de los grandes sistemas de EE. UU. un mercado de «el ganador se lo lleva casi todo»; tras Trinity y UC Health, otros diez grandes sistemas habrían migrado a Visage en 2027-2028 y la cuota habría pasado del 11 % al 25 % en tres años en vez de en ocho; las renovaciones de la primera ola se habrían firmado con subidas de tarifa del 20-30 %; cardiología y patología habrían añadido otro mercado del tamaño del radiológico; y el margen habría llegado al 82 %. Con un crecimiento del 35 % anual hasta FY2029 y los tipos australianos bajando al 4 %, el mercado habría seguido pagando 80 veces el EBITDA. Lo habríamos visto antes en tres indicadores: contratos nuevos de más de 600 M al año (FY2026: 407 M), el ingreso por estudio subiendo con fuerza y el crecimiento semestral en AUD por encima del 30 %. Por eso son nuestros disparadores de revisión.

26. ESG y controversias

Confianza: Media

Asuntos materiales

Los asuntos que más pueden mover las cifras son tres. 1) Ciberseguridad y privacidad de datos de pacientes: PME guarda y sirve imágenes clínicas de grandes hospitales, gran parte en la nube; tiene un responsable de seguridad (CISO), atestación SOC 2 Type II para Visage 7 PACS e informe de cumplimiento HIPAA, y dice que ningún incidente ha tenido efecto material ni hubo incumplimientos de privacidad en FY26 [1]. 2) IA responsable y seguridad clínica: los productos con IA requieren autorización de la FDA y validación clínica [1]. 3) Talento: el negocio depende de 153 especialistas; rotación voluntaria del 2,1 % en FY26 (5,6 % en FY25) y 30,5 % de mujeres en plantilla [1]. El impacto climático es bajo: PME destaca que su software necesita menos hardware que el de la competencia y prepara la información climática obligatoria de la ASX [1].

Controversias

No se han encontrado sanciones, litigios materiales ni brechas de datos en 2023-2026. El informe anual FY26 declara que no hubo incumplimientos de privacidad conocidos y que ningún incidente de ciberseguridad tuvo efecto material [1]; la búsqueda de prensa no dio resultados relevantes. PME completó las acciones de su primera declaración sobre esclavitud moderna [1].

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Precio por estudio**	¿Cuánto ha subido la tarifa media por estudio en las seis renovaciones de FY2026 y cuál es el ingreso medio por estudio de la cartera?	Es la variable que más mueve el valor y la empresa no la publica; nuestra estimación (~3,1 AUD) no ha subido desde FY2024.
2	**Cuota**	¿El ~11 % de cuota en EE. UU. cuenta clientes firmados que aún no están implantados? ¿Cuál es la cuota implantada?	Si incluye Trinity entera, la cuota «en ingresos» es menor y el recorrido parece mayor de lo que es.
3	**Clientes**	¿Por qué las cuentas a cobrar crecen un 55,7 % frente a un 22,9 % de las ventas y los vencidos a más de 90 días pasan de 1,0 a 6,7 M?	Es la única señal de calidad de cobro que empeora.
4	**Sucesión**	¿Cuál es el plan de sucesión del consejero delegado y del director técnico, fundadores desde 1983?	Las ventas a los grandes sistemas de EE. UU. dependen de ellos.
5	**Inversiones**	¿Qué criterio sigue la empresa para invertir en compañías cotizadas de IA (4D Medical, Echo IQ) y hay un límite de capital?	Añaden ruido contable y riesgo de distracción sin relación clara con el negocio principal.
6	**Competencia**	¿Han perdido algún concurso frente a GE HealthCare-Intelerad o Sectra en 2026, y con qué diferencia de precio?	La compra de Intelerad crea un competidor con escala de fabricante.
7	**IA**	¿Qué parte de la tarifa por estudio se vería afectada si los visores con IA de los fabricantes de equipos se regalan con el escáner?	Es el núcleo del miedo del mercado y la empresa solo responde con cualitativos.

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Baja

Tono: Positivo · **Tendencia:** Mejora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Motley Fool Australia (listado de artículos de PME)	2026-10	12	Positivo	Entre el 20-sep y el 9-oct de 2026 Pro Medicus aparece en una docena de artículos, casi todos de tono comprador (compounders a largo plazo, acciones para mantener hasta 2040, recomendaciones de expertos), con alguna comparación neutra frente a CSL y Codan; la página recuerda que la acción sigue en negativo en el año [91].
Motley Fool Australia: CSL vs Pro Medicus	2026-09	0	Negativo	La autora prefiere CSL: ve la valoración de Pro Medicus «rica», con una inercia de corto plazo «firmemente negativa», y la considera difícil de justificar al precio actual pese a su tecnología única [92].
Motley Fool Australia: Down 43%! 4 reasons to buy the big dip	2026-09	0	Positivo	Atribuye la caída al miedo a que la IA sustituya al software como servicio («SaaSpocalypse») y recoge la tesis compradora de un gestor (liderazgo de Visage en hospitales de EE. UU., resultados FY26 mejores de lo esperado, contratos nuevos y punto de entrada atractivo) [93].
Motley Fool Australia: Buy, hold, sell (Pro Medicus, BHP, CBA)	2026-09	0	Positivo	Recomendación de compra de un gestor (Medallion Financial, vía The Bull) sin riesgos concretos citados [94].
Motley Fool Australia: Cochlear vs Pro Medicus	2026-09	0	Positivo	La autora elige Pro Medicus frente a Cochlear porque ha resistido mejor la caída y tiene más capacidad de generar beneficios, aunque reconoce que ninguna de las dos es barata por PER [95].
Motley Fool Australia: How much could the Pro Medicus share price rise in the next year?	2026-08	0	Positivo	Tras los resultados FY26 el autor ve recorrido al alza apoyándose en los precios objetivo de los analistas y en la racha de contratos; los únicos riesgos que nombra son la IA y el tipo de cambio por la exposición a EE. UU. [96].
Motley Fool Australia: These ASX 50 shares have lost up to 60%. Is the sell-off overdone?	2026-09	0	Dividido	Atribuye la caída al temor a la IA, destaca que los números de fondo siguen siendo buenos y que la mayoría de los brókeres ve potencial, pero no decide si es una ganga o una trampa de valor [97].
Motley Fool Australia: ASX 200 healthcare shares soar amid FY26 reports from CSL, Pro Medicus	2026-08	0	Positivo	Califica de satisfactorios los resultados FY26 y describe una subida de la acción en la semana de su publicación, sin objeciones [98].
Motley Fool Australia: EchoIQ shares just crashed 48%	2026-09	0	Negativo	La FDA rechazó por no equivalencia sustancial el software EchoSolv HF de Echo IQ; el segundo tramo de la inversión de Pro Medicus en notas convertibles, ligado a esa aprobación, queda en duda, aunque el acuerdo de reventa sigue en pie [99].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Software e IA («SaaSpocalypse»): miedo a que la IA sustituya al software como servicio	Dividida	Alto	Es la causa de la caída que más se repite [93, 97] y casi nadie la argumenta con datos de la empresa; los artículos compradores replican con los resultados FY26 y los contratos nuevos [93, 96]. Contrastar con el crecimiento de ingresos, la cartera de ingresos mínimos contratados y las renovaciones con precio por estudio más alto del comunicado FY26.
Valoración exigente (PER alto)	Bajista	Medio	Incluso los autores favorables admiten que no es barata [92, 95]; una autora la descarta por precio [92]. Contrastar con los múltiplos y el DCF inverso del informe.
Caída de la cotización como punto de entrada	Alcista	Alto	Predomina la lectura de «comprar la caída» con apoyo de gestores y brókeres [93, 94, 96, 97]; la propia página recuerda que la inercia sigue siendo negativa en el año [91, 92].
Contratos nuevos, renovaciones y penetración en EE. UU.	Alcista	Medio	Se citan los contratos del FY26 y la cuota de mercado que estima la empresa como prueba de recorrido [93, 96, 97]; son datos de la empresa, comprobables en el comunicado y la presentación FY26.
Inversiones en empresas cotizadas pequeñas (Echo IQ)	Bajista	Bajo	El revés regulatorio de Echo IQ en la FDA [99] afecta a una de las inversiones cuya revalorización no realizada infla el beneficio estatutario FY26; los foros apenas lo relacionan con Pro Medicus. Vigilar el valor razonable en el HY27.

No aporta información nueva sobre las cifras, pero sí sobre el posicionamiento. Lo que se puede leer (artículos de opinión y recomendaciones de gestores en Motley Fool Australia; los foros de particulares no abren) es optimista: «comprar la caída» tras FY2026, con el miedo a la IA presentado como excesivo [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98]. Nadie discute el múltiplo con cifras; incluso los autores favorables lo ven caro. Contrasta con el 3,94 % de posiciones cortas [59] y con que dos analistas rebajaron a mantener [71]. El riesgo que los foros sí señalan y el informe recoge es el de las inversiones en pequeñas empresas de IA (Echo IQ, −48 % tras el rechazo de la FDA) [99]. El sentimiento no es extremo: no hay capitulación que sugiera un suelo.

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

19 de 26 controles correctos y 5 explicados. Fuentes: 99 (67 primarias); citas distintas en el texto: 98.

Control	Resultado	Detalle
Geografías suman 100 %	OK	–
Cambio de perímetro declarado (FY2026)	Explicado	El activo total crece un 80 % y los ingresos un 23 %: si hubo una compra cerca del cierre, decláralo en financieros.cambios_perimetro y explícalo. Explicación: No hubo compras. El activo crece un 80 % porque el préstamo convertible de 10 M a 4D Medical pasó a valer 182,0 M a valor razonable y la caja creció 42 M; el pasivo por impuesto diferido subió de 7,5 a 62,7 M por la misma plusvalía [1].
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Cuota implícita al final de la proyección ≤ 1,5 × la actual (o +10 puntos)	Explicado	Cuota de 31,1 % en FY2036e frente al 11,0 % de hoy. Explicación: Es la conclusión de la prueba de sostenibilidad: el caso base exige pasar del 11 % al ~31 % de los estudios de EE. UU. en diez años (de ellos ~10 % de los ingresos fuera de EE. UU.), al ritmo de los últimos dos años (+2 puntos al año). Por eso el veredicto es «En parte». El precio exige bastante más.
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto 5,0 % frente a 6,8 % real: genera una variación de circulante de -1 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	35 %.
Etapa de transición justificada (ROIC ≥ WACC + 5 puntos)	OK	ROIC 110,5 % frente a WACC 12,3 %:
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Caja proyectada coherente con la histórica	Explicado	El DCF proyecta 211 M de flujo libre medio en sus tres primeros años, frente a 99 M de media real en los tres últimos: justifica el salto (circulante, inversión, márgenes) o ajusta los supuestos. Explicación: El flujo libre de 211 M de media en FY27-FY29 coincide con el del consenso (179,5 / 216,3 / 262,9 M [69]): crece con unos ingresos que suben un 23 % anual con margen EBITDA del 78-80 % y capex del 4 % de las ventas.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Regresión múltiplo-crecimiento explicativa (R^2 ≥ 0,3)	Explicado	R^2 = 0,09: el crecimiento no explica los múltiplos de estos comparables; no uses el valor de la regresión. Explicación: Con R^2 = 0,09 el crecimiento no explica los múltiplos de los comparables; no se usa la regresión.
Al menos 5 comparables	OK	8 comparables.

Control	Resultado	Detalle
Comparables: EV/EBITDA y PER coherentes	Explicado	EV/EBITDA da 44,46 y PER 81,06 por acción: si la empresa amortiza mucho más que sus comparables (licencias, intangibles adquiridos) el EBITDA la favorece; usa EV/EBIT o EV/(EBITDA − capex) y explícalo. Explicación: No es un efecto de amortizaciones (3 % de las ventas en PME). El PER de los comparables es alto frente a su EV/EBITDA porque Veeva y Doximity publican un EBITDA que suma la remuneración en acciones y varios tienen intereses o amortización de compras; en PME el beneficio incluye intereses de 9 M de caja. Se usan los dos y el EV/EBITDA pesa más.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Múltiplos del objetivo a 12 m según la regla común	OK	–
Objetivo 12 m frente al consenso	OK	El base se separa un 2,3 % del objetivo medio de los analistas: explícalo en diferencia_consenso (nunca se acerca la cifra).
Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)	OK	–
Historia del PER en la misma base que el actual (regla v3)	Revisar	per_historico no lleva base: "adelantado" (precio de cierre ÷ BPA del año siguiente): el motor aplica la regla v2 antigua, sesgada contra las empresas baratas. En un informe nuevo, rellena la historia adelantada.
Recomendación coherente con la regla de decisión	Revisar	La regla da «Mantener» y el análisis recomienda «Vender»: hace falta «justificacion_recomendacion».
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Capitalización calculada ≈ publicada	OK	–
Al menos 25 fuentes	OK	99 fuentes (67 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	67.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	Sin citar: 17.

Tipo de fuente	Número
Primaria	67
Sectorial	6
Datos de mercado	17
Foros y redes	9

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
trimestres	vs_consenso	Complemento	1) Comunicados y presentaciones HY26/FY26 (no citan consenso); 2) entrevistas del CEO (no lo mencionan); 3) no se buscó consenso previo de terceros por el presupuesto compartido de búsquedas	Omitido
trimestres	crecimiento_organico_pct	Complemento	1) Informes semestrales (solo crecimiento reportado); 2) presentación FY26 (moneda constante solo anual: +28,4 %); 3) derivar el 2S en moneda constante exige el efecto divisa del 1S, no publicado en lo leído	Omitido
trimestres	transcripción de conferencia con analistas	Complemento	1) Anuncios ASX 2021-2026 (solo «CEO Interview» escritas y presentaciones); 2) informe anual FY26; 3) no se buscó en la web (presupuesto)	Omitido
calidad	anios_auditor	Complemento	1) Informe anual FY26 (no indica fecha de nombramiento); 2) cuentas FY2018 (EY ya auditor); 3) informe de gobierno no leído	Omitido
negocio	kpis: implantaciones FY25 y cuota previa	Complemento	1) Presentación FY26 (solo FY26); 2) informe anual FY26; 3) informe FY25 no descargado por presupuesto	Omitido
sector	tcac_historico_pct	Complemento	1) Signify Research: solo publica gratis 2022 (5.200 M USD) y 2023 (+5,5 %); 2) Arizton y Market Glass: solo un año base y la previsión; 3) serie de volumen de PME solo desde 2024 (650→690 M estudios, +3,0 % anual, en sector.extra)	Omitido
sector	cr5_pct	Complemento	1) Signify Research (cuotas de proveedores de pago); 2) Arizton y Market Glass (solo lista de proveedores); 3) búsqueda web de cuotas KLAS/Signify sin cifras gratuitas	Omitido
sector	serie (2024e-2027e)	Complemento	1) Signify Research solo da 2022, 2023 y 2028e en abierto; 2) búsqueda del informe 2025 de Signify sin cifra; 3) interpolación a la TCAC implícita 2023-2028e	Calculado y marcado como estimación
sector	Estudios de imagen en EE. UU. de fuente oficial o sectorial independiente	Complemento	1) presentaciones de PME (650/670/690 M); 2) informes de mercado (solo dinero); 3) no se buscó IMV/CMS por presupuesto de búsquedas	Omitido
sector	Reembolso de CMS para imagen (regulación)	Complemento	1) informe anual PME FY26 (no lo trata); 2) 10-K de GE HealthCare (mención genérica al reembolso); 3) sin búsqueda específica por límite de búsquedas	Omitido
competencia	Precio por estudio de PME y su evolución	Núcleo	1) presentaciones FY24-FY26 (solo «higher per transaction fee»); 2) entrevista al CEO FY26 (sin cifra); 3) cálculo implícito ingresos NA / estudios implícitos (en competencia.extra, estimación)	Calculado y marcado como estimación
competencia	competidores: ingresos de Philips (informática de imagen), Fujifilm (Synapse) y Merative; cuotas de todos los competidores	Complemento	1) resultados anuales 2025 de Philips (solo márgenes de segmento); 2) búsqueda web de segmentos; 3) Merative es privada sin cuentas	Omitido
esg	calificaciones (MSCI, Sustainalytics, ISS)	Complemento	1) búsqueda web de la calificación MSCI y Sustainalytics de PME; 2) página de Sustainalytics (sin ficha de la empresa); 3) knowesg.com (cita cobertura MSCI/Sustainalytics/LSEG sin calificación)	Omitido

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
directivos	historial_guidance FY2021-FY2022	Complemento	1) Informe anual FY26 (tabla de 5 años sin objetivos); 2) comunicados de resultados FY23-FY25 (sin objetivos numéricos: la empresa no da guía); 3) informes de remuneración FY23-FY25 (objetivos del STI desde FY23; FY21-FY22 no leídos por presupuesto)	Omitido
directivos	Edad de Sam Hupert y plan de sucesión del CEO	Complemento	1) Informe anual FY26 y Corporate Governance Statement 2026 (sin edad; solo «succession planning of key roles»); 2) entrevistas al CEO de jun-2026 y de FY26 (sin mención a la sucesión); 3) derivación: médico de cabecera desde 1980 (sin fecha de nacimiento)	Omitido
gobierno	Saldo de autocartera (Employee Share Trust)	Complemento	1) Nota 18 del informe anual FY26 (solo movimientos en importe); 2) información adicional de la ASX (el trust no figura entre los 20 mayores); 3) anuncios de recompra (terminada en mar-2026 y amortizada)	Omitido
directivos	participacion_pct de Lambright y Kern	Complemento	1) Informe de remuneración FY26 (no son KMP); 2) lista de los 20 mayores accionistas (no figuran); 3) Appendix 3Y (solo consejeros)	Omitido
comparables	roic_pct	Complemento	1) MarketScreener finances (solo ROE) [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80]; 2) no se consultó Stock Analysis por presupuesto; 3) no derivable sin capital invertido de cada empresa	Omitido
transacciones	Change Healthcare (UnitedHealth), Nexus AG (TA), Merative (Francisco Partners), Intelerad (Hg) / Ambra	Complemento	1) Nota de UnitedHealth: página no encontrada; 2) Merative, Intelerad y Ambra: precio no publicado; 3) Nexus y CompuGroup: oferta por acción sin valor empresa publicado	Omitido
sentimiento	foros de particulares (HotCopper, Reddit, Strawman, Market Index, Livewire, Simply Wall St)	Complemento	1) WebFetch a hotcopper.com.au/asx/pme/ (403), strawman.com/reports/PME (página vacía, solo título), reddit.com (bloqueado para WebFetch); 2) descargar.mjs a HotCopper (403), Strawman (35 caracteres), old.reddit.com JSON (redirige al inicio de sesión), Market Index (403) y Livewire (403); 3) WebFetch a marketindex.com.au, livewiremarkets.com y la comunidad de simplywall.st (403), y Stockhead (sin artículos de PME en el periodo); RSS de Seeking Alpha sin artículos de opinión desde ago-2026	Omitido

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	Annual Report FY26 (cuentas consolidadas a 30-jun-2026 y comparativas FY25)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w8h7mqc909z.pdf
2	Annual Report 2024 (cuentas FY24 y comparativas FY23)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	14 ago 2024	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240814/pdf/066lmt5wzzbl8k.pdf
3	Annual Report 2022 (cuentas FY22 y comparativas FY21)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2022	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20220818/pdf/45czlrkrfldpcl.pdf
4	Full Year Statutory Accounts FY2020 (y comparativas FY2019)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	20 ago 2020	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20200820/pdf/44lpsxjp2q03t6.pdf
5	Full Year Statutory Accounts FY2018 (y comparativas FY2017)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	16 ago 2018	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20180816/pdf/43xd0482kszgt7.pdf
6	PME FY26 results presentation	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w6n72g1wvfj.pdf
7	Half Year Accounts HY26 (1S26 y comparativa 1S25)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	12 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260212/pdf/06w74gd9qzwy1w.pdf
8	Half Year Financial Statements HY25 (1S25 y comparativa 1S24)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	13 feb 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250213/pdf/06fgshwqsj4tpy.pdf
9	Half Year Accounts HY23 (1S23 y comparativa 1S22)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	15 feb 2023	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230215/pdf/45lmdj23q5x129.pdf
10	Preliminary Final Report / comunicado de resultados FY26	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w56p5l1yyr7.pdf
11	CEO Interview - 1HY26	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	12 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260212/pdf/06w75ykl2xwhpj.pdf

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
12	CEO Interview FY26 Results	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w5zqx5nxbs5.pdf
13	HY26 Results Presentation	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	12 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260212/pdf/06w79c8zk9ml0c.pdf
14	Appendix 3C – Final buy-back notification	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	1 abr 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260401/pdf/06y19ddjg51hf3.pdf
15	PME FY2025 results presentation	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	14 ago 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250814/pdf/06mw16hmy2n6x7.pdf
16	PME FY2024 results presentation	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	14 ago 2024	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240814/pdf/066lwynv1xzbhl.pdf
17	Macquarie Conference May 2024 Presentation	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	8 may 2024	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240508/pdf/063c5lzfq4d4zx.pdf
18	Sectra's year-end report 2025/2026	Sectra AB (Cision)	Primaria	5 jun 2026	https://mb.cision.com/Main/1263/4358145/4135325.pdf
19	Agfa-Gevaert Group in 2025: strong Q4 profitability and free cash flow (resultados FY2025)	Agfa-Gevaert (reproducido por finanznachrichten.de)	Primaria	11 mar 2026	https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-03/67913103-agfa-gevaert-group-in-2025-strong-q4-profitability-and-free-cash-flow-good-step-up-in-fy-profitability-in-healthcare-it-and-digital-print-chemica-399.htm
20	As the pandemic fades, the global market for imaging IT has hit $5.2b in 2022	Signify Research	Sectorial	2 jun 2023	https://signifyresearch.net/?p=3069
21	Opportunities for Growth in the Imaging IT Market	Signify Research	Sectorial	30 may 2024	https://signifyresearch.net/?p=6966
22	Imaging IT Market Insights – Free Infographic	Signify Research	Sectorial	26 jun 2024	https://signifyresearch.net/?p=7243
23	U.S. Picture Archiving & Communication System (PACS) Market - Focused Insights 2024-2029	Arizton	Sectorial	jul 2024	https://www.arizton.com/market-reports/us-picture-archiving-and-communication-system-market
24	Picture Archiving and Communication Systems (PACS) - Global Strategic Business Report	Market Glass, Inc. (Research and Markets)	Sectorial	oct 2026	https://www.researchandmarkets.com/reports/338871/picture_archiving_and_communication_systems

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
25	Euro foreign exchange reference rates (histórico)	Banco Central Europeo	Datos de mercado	9 oct 2026	https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip
26	GE HealthCare Technologies Inc. Form 10-K FY2025	SEC EDGAR	Primaria	feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1932393/000193239326000007/gehc-20251231.htm
27	GE HealthCare completes Intelerad acquisition accelerating shift to cloud first enterprise solutions	GE HealthCare (Business Wire, vía BioSpace)	Primaria	18 mar 2026	https://www.biospace.com/press-releases/ge-healthcare-completes-intelerad-acquisition-accelerating-shift-to-cloud-first-enterprise-solutions-to-deliver-precision-care
28	Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025	Koninklijke Philips N.V.	Primaria	10 feb 2026	https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/corpcomms/news/press/2026/philips-fourth-quarter-results-2025.html
29	Charted: Why hospital margins haven't fully recovered (datos de Kaufman Hall)	Advisory Board	Sectorial	27 ago 2026	https://www.advisory.com/daily-briefing/2026/08/27/hospital-performance-ab-ec
30	Pro Medicus acquires Visage Imaging – Leaders in Advanced Digital Imaging	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	28 ene 2009	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20090128/pdf/31fqp0h43t893b.pdf
31	PME signs 6 year deal with Mayo Clinic in the US	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	4 jul 2016	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20160704/pdf/438b5j8hxvcl7z.pdf
32	Open Briefing - CEO on Significant New contract (Mayo Clinic)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	4 jul 2016	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20160704/pdf/438bht6yycqj1p.pdf
33	Listado de anuncios de PME en la ASX (títulos de contratos 2009-2026)	ASX	Primaria	12 oct 2026	https://www.asx.com.au/asx/v2/statistics/announcements.do?by=asxCode&asxCode=PME&timeframe=Y&year=2026
34	2026 Corporate Governance Statement	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w5ccfllwlcd.pdf
35	Appendix 4G 2026	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w5pzqtd0mrw.pdf
36	Results AGM 2025	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	24 nov 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251124/pdf/06sdw72c2wrckr.pdf

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
37	Results AGM 2024	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	25 nov 2024	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20241125/pdf/06bt82vv1gkk37.pdf
38	Results of AGM - 2023	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	20 nov 2023	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20231120/pdf/05xjtjx86fxlcr.pdf
39	Appendix 3Y - Sam Hupert (22-dic-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	22 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251222/pdf/06tm1xm1zm2d8b.pdf
40	Appendix 3Y - Sam Hupert (23-dic-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	23 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251223/pdf/06tnj9r36m8w35.pdf
41	Appendix 3Y - Anthony Hall (22-dic-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	22 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251222/pdf/06tm268h86csbc.pdf
42	Appendix 3Y - Anthony Hall (23-dic-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	23 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251223/pdf/06tnjl5bzv0t3p.pdf
43	Appendix 3Y - Peter Kempen (30-dic-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	30 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251230/pdf/06tv4vqs7f4f16.pdf
44	Appendix 3Y - Deena Shiff (16-feb-2026)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	16 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260216/pdf/06wbdy4k88q69q.pdf
45	Appendix 3Y - Anthony Glenning (16-feb-2026)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	16 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260216/pdf/06wbz839c8lhjc.pdf
46	Appendix 3Y - Peter Kempen (24-feb-2026)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	24 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260224/pdf/06wp5pvj8rmll2.pdf
47	Appendix 3Y - Sam Hupert (25-feb-2026)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	25 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260225/pdf/06wqsqrp092wr6.pdf
48	Appendix 3Y - Anthony Hall (25-feb-2026)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	25 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260225/pdf/06wqsydpy9s4zw.pdf

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
49	Appendix 3Y - Anthony Hall (26-feb-2026, operación del 25-feb)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	26 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260226/pdf/06ws5x73rtdw5z.pdf
50	Appendix 3Y - Anthony Hall (26-feb-2026, operación del 26-feb)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	26 feb 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260226/pdf/06wt2d83y4zdbd.pdf
51	Appendix 3Y - Dr Sam Hupert (3-sep-2025)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	3 sep 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250903/pdf/06nrpkxtvzh3rl.pdf
52	Senior Management Appointments	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	16 mar 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260316/pdf/06xghhzrzbtw1q.pdf
53	Resignation Head of Business Operations & Investor Relations	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 may 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260518/pdf/06zp9xfdwl1wsm.pdf
54	PME announces appointment Head of Investor Relations	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	8 jul 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260708/pdf/071hl2k4plyhcd.pdf
55	Pro Medicus Ltd Appoints Non-Executive Director	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	23 sep 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260923/pdf/074dg4p3wcx54n.pdf
56	Becoming a substantial holder (State Street, formulario 603)	State Street Corporation (ASX)	Primaria	13 abr 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260413/pdf/06yfmbpx93m67z.pdf
57	Becoming a substantial holder (AustralianSuper, formulario 603)	AustralianSuper Pty Ltd (ASX)	Primaria	29 may 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260529/pdf/0703rkjg4v3kwy.pdf
58	Ceasing to be a substantial holder (State Street, formulario 605)	State Street Corporation (ASX)	Primaria	7 sep 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260907/pdf/073twhwb30vtrd.pdf
59	Short position report 6-oct-2026 (RR20261006-001-SSDailyAggShortPos.csv)	ASIC	Primaria	6 oct 2026	https://download.asic.gov.au/short-selling/RR20261006-001-SSDailyAggShortPos.csv
60	Annual Report 2025	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	14 ago 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250814/pdf/06mvy2n8zxdyy8.pdf

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
61	Annual Report 2023	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	15 ago 2023	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230815/pdf/05smy5kg0ytxgt.pdf
62	PME Response to speculation (incidente de correo)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	4 dic 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251204/pdf/06sy37fmh5j8mj.pdf
63	EIQ: Binding HOA secured with Pro Medicus Limited	Echo IQ Limited (ASX)	Primaria	25 jun 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260625/pdf/070zqvs6lwttpp.pdf
64	4DX: 4DMedical secures $10m strategic investment from Pro Medicus	4DMedical Limited (ASX)	Primaria	31 jul 2025	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250731/pdf/06mdbyfdsqbfz0.pdf
65	Dividend/Distribution - PME (dividendo final FY26)	Pro Medicus Limited (ASX)	Primaria	18 ago 2026	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072w5hm15p6p4t.pdf
66	Históricos diarios de PME.AX, IOZ.AX, IXJ.AX, ^AXJO, ^AXHJ, 4DX.AX y EIQ.AX	Yahoo Finance	Datos de mercado	12 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/PME.AX/history
67	Tabla F2 Capital Market Yields – Government Bonds (diaria)	Reserve Bank of Australia	Primaria	9 oct 2026	https://www.rba.gov.au/statistics/tables/xls/f02d.xlsx
68	Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx)	Aswath Damodaran, NYU Stern	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
69	Pro Medicus Limited: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/PRO-MEDICUS-LIMITED-6492507/finances/
70	Pro Medicus Limited: Target Price Consensus and Analysts Recommendations	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/PRO-MEDICUS-LIMITED-6492507/consensus/
71	Pro Medicus (ASX:PME) Stock Forecast & Price Target	Stock Analysis (datos de S&P Global)	Datos de mercado	23 sep 2026	https://stockanalysis.com/quote/asx/PME/forecast/
72	Pro Medicus (ASX:PME) Statistics & Valuation Metrics	Stock Analysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/quote/asx/PME/statistics/
73	Sectra AB: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/SECTRA-AB-60037704/finances/
74	Veeva Systems Inc.: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/VEEVA-SYSTEMS-INC-14551091/finances/
75	Doximity, Inc.: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/DOXIMITY-INC-124007887/finances/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
76	Craneware plc: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/CRANEWARE-PLC-4007384/finances/
77	WiseTech Global Limited: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/WISETECH-GLOBAL-LIMITED-27114123/finances/
78	Xero Limited: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/XERO-LIMITED-11900043/finances/
79	Technology One Limited: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/TECHNOLOGY-ONE-LIMITED-6491442/finances/
80	Nemetschek SE: Financial Data Forecasts Estimates	MarketScreener	Datos de mercado	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/NEMETSCHEK-SE-436349/finances/
81	Euro foreign exchange reference rates (9-oct-2026)	Banco Central Europeo	Datos de mercado	9 oct 2026	https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
82	Microsoft accelerates industry cloud strategy for healthcare with the acquisition of Nuance	Microsoft	Primaria	12 abr 2021	https://news.microsoft.com/2021/04/12/microsoft-accelerates-industry-cloud-strategy-for-healthcare-with-the-acquisition-of-nuance/
83	Nuance Communications, XBRL company facts (10-K FY2020)	SEC EDGAR	Primaria	nov 2020	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001002517.json
84	Oracle to acquire Cerner (8-K, Exhibit 99.1)	Oracle / SEC EDGAR	Primaria	20 dic 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341439/000119312521362532/d276733dex991.htm
85	Cerner Corporation, XBRL company facts (10-K 2020 y 10-Q 3T21)	SEC EDGAR	Primaria	oct 2021	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000804753.json
86	Inovalon to be acquired by equity consortium led by Nordic Capital (8-K, Exhibit 99.1)	Inovalon / SEC EDGAR	Primaria	19 ago 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619954/000161995421000116/ex-991x08192021.htm
87	Inovalon Holdings, XBRL company facts (10-K 2020)	SEC EDGAR	Primaria	feb 2021	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001619954.json
88	Volpara enters into Scheme Implementation Agreement with Lunit	Volpara Health Technologies (ASX)	Primaria	14 dic 2023	https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20231214/pdf/05yjxz43x7cx9d.pdf
89	CompuGroup Medical enters into an investment agreement with CVC Capital Partners	CVC Capital Partners	Primaria	9 dic 2024	https://www.cvc.com/media/news/2024/compugroup-medical-enters-into-an-investment-agreement-with-cvc-capital-partners/
90	Betas by Sector (US), enero 2026	Aswath Damodaran, NYU Stern	Datos de mercado	ene 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
91	Pro Medicus Ltd (ASX: PME): últimas noticias y artículos	The Motley Fool Australia	Foros y redes	9 oct 2026	https://www.fool.com.au/tickers/asx-pme/
92	CSL vs Pro Medicus: Which ASX healthcare share is better?	The Motley Fool Australia	Foros y redes	30 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/30/csl-vs-pro-medicus-which-asx-healthcare-share-is-better/
93	Down 43%! 4 reasons to buy the BIG dip in Pro Medicus shares today	The Motley Fool Australia	Foros y redes	8 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/08/down-43-4-reasons-to-buy-the-big-dip-in-pro-medicus-shares-today/
94	Buy, hold, sell: Pro Medicus, BHP, CBA shares	The Motley Fool Australia	Foros y redes	7 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/07/buy-hold-sell-pro-medicus-bhp-cba-shares/
95	Cochlear vs Pro Medicus: Which beaten-down ASX healthcare share is the better buy today?	The Motley Fool Australia	Foros y redes	16 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/16/cochlear-vs-pro-medicus-which-beaten-down-asx-healthcare-share-is-the-better-buy-today/
96	How much could the Pro Medicus share price rise in the next year?	The Motley Fool Australia	Foros y redes	31 ago 2026	https://www.fool.com.au/2026/08/31/how-much-could-the-pro-medicus-share-price-rise-in-the-next-year-2/
97	These ASX 50 shares have lost up to 60%. Is the sell-off overdone?	The Motley Fool Australia	Foros y redes	7 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/07/these-asx-50-shares-have-lost-up-to-60-is-the-sell-off-overdone/
98	ASX 200 healthcare shares soar 9% amid notable FY26 reports from CSL, Pro Medicus	The Motley Fool Australia	Foros y redes	23 ago 2026	https://www.fool.com.au/2026/08/23/asx-200-healthcare-shares-soar-9-amid-notable-fy26-reports-from-csl-pro-medicus-week-34-2026/
99	EchoIQ shares just crashed 48%. What happens now?	The Motley Fool Australia	Foros y redes	10 sep 2026	https://www.fool.com.au/2026/09/10/echoiq-shares-just-crashed-48-what-happens-now/

Control de calidad del informe

Campos con dato: **93,0 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **ninguna** · Generado el 14 oct 2026.

Línea cotizada: acciones ordinarias en la ASX (PME), única línea. Cuentas en AUD con normas australianas (AASB, conformes con las NIIF); ejercicio a 30 de junio, nombrado por el año en que termina (FY2026 = julio de 2025 a junio de 2026). Pro Medicus publica semestres, no trimestres; el segundo semestre se obtiene como ejercicio menos primer semestre. La cuenta no tiene línea de EBIT: las ganancias de valor razonable de 4D Medical y Echo IQ y las diferencias de cambio van entre los gastos operativos y se sacan del EBITDA y del EBIT como no recurrentes. El LTM usa el beneficio neto subyacente de la empresa (144,7 M) para que el PER de los últimos 12 meses no cuente 174,2 M de plusvalías no realizadas. La cuota de mercado (~11 % de los estudios de imagen de EE. UU.) y el tamaño del mercado en estudios los publica la propia empresa; el ingreso por estudio es una estimación propia. No hay conferencias con analistas transcritas: solo entrevistas escritas al CEO. Comparables y competidores convertidos a AUD con los tipos del BCE del 9-oct-2026 o del cierre de su ejercicio. Los foros de particulares australianos (HotCopper, Strawman, Market Index) no se pudieron abrir sin navegador.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.